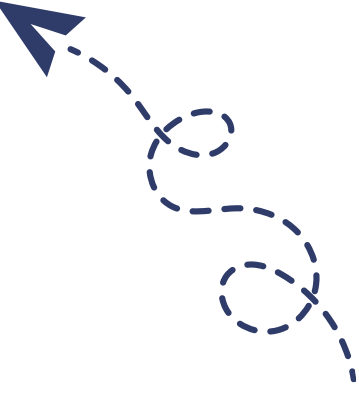




قناة تانية تمريضيانو على التليجرام



قائمة المحتوى

صفحة	المحتوى
	1. الفصل الأول أ. (تمريض صحة المجتمع) • مقدمة في تمريض صحة المجتمع • تعريف المجتمع. • تمريض صحة المجتمع. • أهداف تمريض صحة المجتمع. • دور ممرضة صحة المجتمع. ب. الصحة والمرض • تعريف الصحة والمرض. • تحديد الصحة والمرض. • العوامل الأساسية للوصول إلى صحة جيدة. • الوقاية من الأمراض. ج. الفريق الصحي • تعريف الفريق الصحي. • دور الفريق الصحي في رعاية الأسرة. • عوامل نجاح الفريق الصحي. • أعضاء الفريق الصحي. • دور الفريق الصحي. • العوامل التي تساعد على رفع كفاءة الفريق الصحي
	2. الفصل الثاني أ. الرعاية الصحية الأولية • تعريف الرعاية الصحية الأولية. • مبادئ الرعاية الصحية الأولية. • عناصر الرعاية الصحية الأولية. • الفريق الصحي في الرعاية الصحية الأولية. • دور الممرضة في تطبيق مبادئ ومفهوم الرعاية الصحية الأولية. ب. صحة الأم والطفل

	• تحديد صحة الأم وصحة الطفل (تصنيف الطفولة) • اشرح سبب إعطاء الأولوية لخدمة صحة الأم والطفل • التعرف على المكون الرئيسي لخدمة صحة الأم والطفل • تحديد خدمات الرعاية الصحية للأم والطفل • شرح المؤشر المشترك لخدمة صحة الأم والطفل • إظهار دور الممرضات في رعاية صحة الأم والطفل.
	3. الفصل الثالث (خدمة الصحة العامة المجتمعية) أ. الزيارات المنزلية وخدمات الرعاية الصحية المنزلية ب. الرعاية الصحية للأسرة • تقييم الأسرة • أزمة عائلية • الإحالة العائلية • دور ممرضة صحة الأسرة. ج. خدمات الصحة المدرسية. د. خدمات صحة المسنين.
	4. الفصل الرابع (الصحة البيئية والمهنية) • بيئة • مهني • الصحة الريفية
	5. الفصل الخامس (المعدية وغير المعدية أمراض) • التواصل • غير معدية • رعاية الفئات الضعيفة

الفصل الأول

(تمريض صحة المجتمع)

أهداف التعلم

في نهاية الفصل سيكون الطالب قادرًا على:-

- تعريف تمريض صحة المجتمع والمجتمع
- التعرف على مفهوم المجتمع
- وصف الخصائص الثمانية للتمريض الصحي المجتمعي.
- تحديد أهداف تمريض صحة المجتمع.
- اذكر دور ممرضة صحة المجتمع.

مقدمة:

تمريض صحة المجتمع، ويسمى أيضًا تمريض الصحة العامة أو تمريض المجتمع، يجمع بين الرعاية الصحية الأولية وممارسة التمريض في بيئة مجتمعية. يقدم ممرضو صحة المجتمع (CH) الخدمات الصحية والرعاية الوقائية والتدخل والتثقيف الصحي للمجتمعات أو السكان. والآن أصبح التركيز منصبًا بشكل أكبر على الشخص المريض والشخص السليم، ومن الفرد إلى المجتمع. في الوقت الحاضر، يُطلق على ممرضات الصحة العامة اسم ممرضات صحة المجتمع وهم ممرضون مسجلون (RN) مدربون على العمل في أماكن الصحة العامة. وهي تشمل خدمات التمريض في جميع مراحل الخدمات الصحية التي يتم تنظيمها من أجل رفاهية المجتمع.

المجتمع:

يشير المجتمع إلى مجموعة من الأشخاص الذين يتفاعلون مع بعضهم البعض و التي تشكل مصالحها أو خصائصها المشتركة الأساس للشعور بالوحدة أو الانتماء.

مجتمع

هي مجموعة من الأفراد المشاركين في تفاعل اجتماعي مستمر، أو مجموعة اجتماعية كبيرة تتقاسم نفس المنطقة المكانية أو الاجتماعية، وعادة ما تخضع ل نفس السلطة السياسية والتوقعات الثقافية السائدة.

تمريض صحة المجتمع

وفقا ل جمعية التمريض الأمريكية (ANA) تمريض صحة المجتمع هو ممارسة تعزيز وحماية صحة السكان باستخدام المعرفة المستمدة من علوم التمريض والعلوم الاجتماعية والصحة العامة

الصحة العامة

غالبًا ما يوصف بأنه فن وعلم الوقاية من الأمراض وإطالة العمر وتعزيز الصحة من خلال الجهود المجتمعية المنظمة لصالح كل مواطن.

صحة المجتمع

ويشير إلى الحالة الصحية لأفراد المجتمع، وإلى المشاكل التي تؤثر على صحتهم، وإلى مجمل الرعاية الصحية المقدمة للمجتمع.

أهداف تمريض صحة المجتمع

الهدف الأساسي لتمريض صحة المجتمع هو

- لتعزيز الصحة والكفاءة.
- للوقاية من الأمراض والإعاقات ومكافحتها.
- لتحسين صحة ورفاهية الأفراد والأسر والمجتمعات.
- للحد من الفوارق الصحية وتعزيز العدالة الصحية، والدفاع عن مجتمعاتهم.
- توفير الرعاية المباشرة وغير المباشرة للأفراد والأسر، وتوفير الدعم والتوجيه والموارد.

مبادئ تمريض صحة المجتمع

- وينبغي التخطيط لها على أساس احتياجات المجتمع.
- ويعتمد على الاحتياجات والوظائف التي تم تحديدها.
- دمج التثقيف الصحي والتوجيه والإشراف مع خدمات التمريض الصحي المجتمعي.
- وينبغي أن تكون الخدمات الصحية واقعية من حيث الموارد المتاحة.
- العلاقة المهنية مع الآداب والكرامة
- مشاركة الفرد وأفراد الأسرة في صنع القرار.
- يجب أن تكون الخدمات الصحية مستمرة.
- السجلات والتقارير الصحيحة ضرورية.
- التقييم السليم للخدمات الصحية

• يجب أن تكون الخدمات الصحية متاحة للجميع دون أي فرق

أدوار تمريض صحة المجتمع

• توفير الرعاية قبل الولادة وأثناءها وبعدها لضمان الحمل والولادة الآمنين.

• إدارة التطعيمات.

• التنسيق مع العيادات الخاصة بالتطعيمات والفحوصات الصحية وتوفير الرعاية للأطفال دون سن الخامسة.

• توفير المحتوى التعليمي والاستشارات

• لتحسين قدرة المجتمع على التعامل مع مشاكله الصحية

• لتعزيز موارد المجتمع

• للوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية ومكافحتها

• لتقديم الخدمات المتخصصة

• لإجراء البحوث

الصحة والمرض

أهداف التعلم

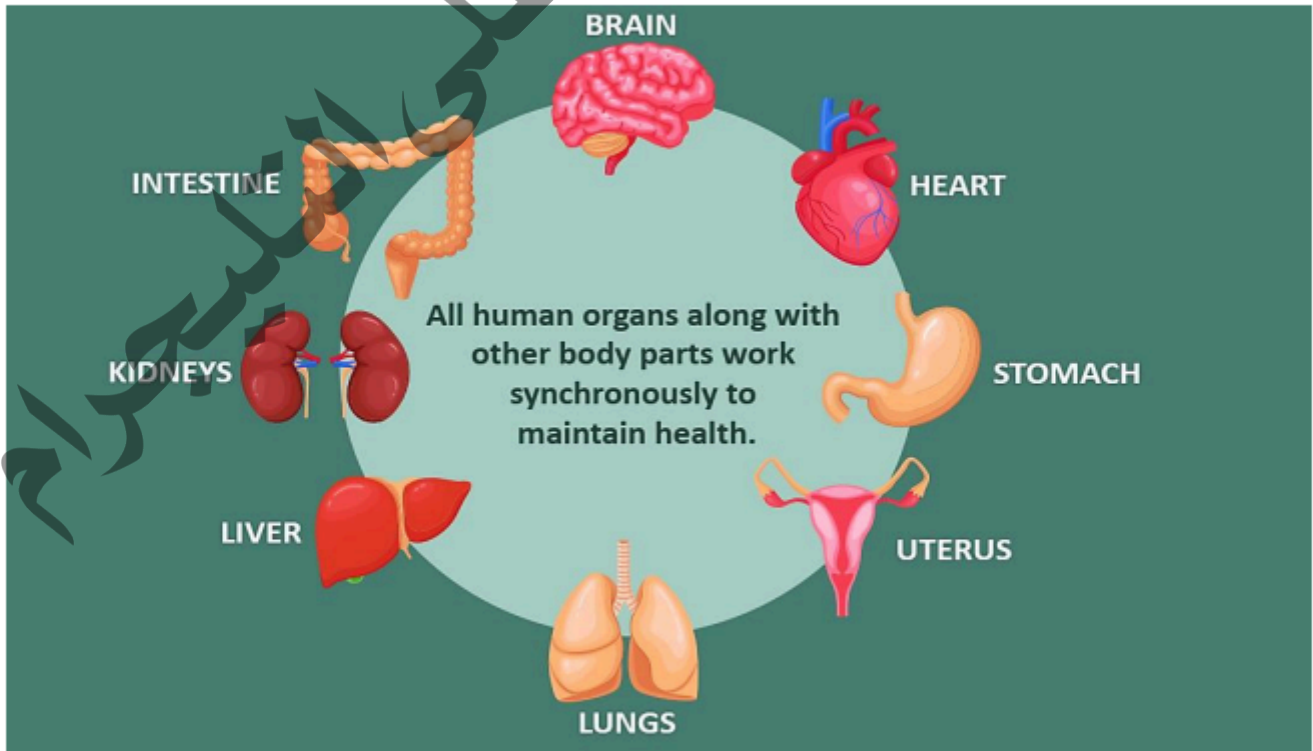
- تعريف الصحة والمرض.
- مناقشة تحديد الصحة والمرض.
- اذكر مؤشرات الصحة والمرض
- وصف العوامل الأساسية للوصول إلى صحة جيدة.
- شرح الوقاية من الأمراض.
- التمييز بين مستويات الوقاية الثلاثة.

مقدمة:

إن جسم الإنسان هو خلق مذهل. هناك العديد من الأنظمة داخل نفس الجسم الذي يعمل بشكل جيد بطريقة منسقة ومتكاملة. لا عجب أن الأمر استغرق بعض الوقت لفهم كيفية عمل جسم الإنسان حقًا الجوانب الأخرى ذات الصلة. اليوم لدينا فهم أفضل لما يشكل الصحة والذي يشمل أيضًا الصحة العقلية. دعونا نلقي نظرة.

صحة:

وفقا ل منظمة الصحة العالمية يتم تعريف الصحة على أنها “حالة اكتمال السلامة البدنية والعقلية والاجتماعية وليس مجرد غياب المرض أو العجز”.



الأمراض:

يشير مصطلح المرض على نطاق واسع إلى أي حالة تؤثر على الأداء الطبيعي للجسم. لهذا السبب، ترتبط الأمراض بخلل في عمليات التوازن الطبيعية في الجسم.

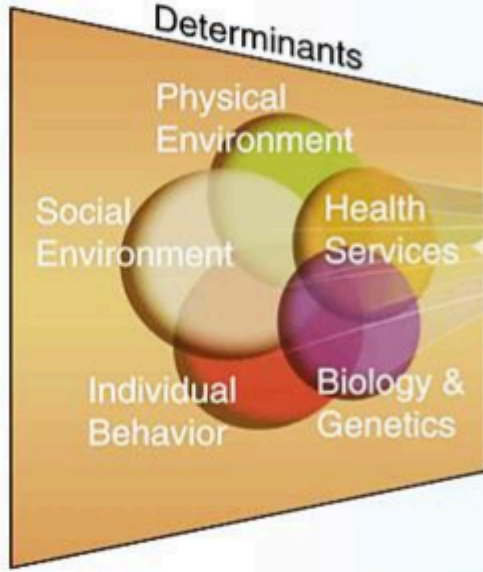
- قد يؤدي فشل أي عضو أو جهاز عضوي أو جزء من الجسم إلى الإصابة بالأمراض
- في بعض الأحيان تسبب الميكروبات العدوى
- العلامات والأعراض تعمل كمؤشرات على تدمير الصحة
- تتعدد أنواع الأمراض وقد يؤدي بعضها إلى عواقب تهدد الحياة وحتى مميتة في غياب التوجيه الطبي المناسب

تشمل محددات الصحة ما يلي:

- البيئة الاجتماعية والاقتصادية،
- البيئة المادية، و
- الخصائص والسلوكيات الفردية للشخص. إن سياق حياة الناس يحدد صحتهم، وبالتالي إلقاء اللوم على الأفراد
- إن اعتبارهم يعانون من سوء الصحة أو اعتبارهم يتمتعون بصحة جيدة أمر غير مناسب. من غير المرجح أن يتمكن الأفراد من التحكم بشكل مباشر في العديد من العوامل التي تحدد الصحة. وتشمل هذه المحددات أو الأشياء التي تجعل الناس أصحاء أو غير أصحاء العوامل المذكورة أعلاه، وغيرها الكثير
- **الدخل والوضع الاجتماعي** - يرتبط ارتفاع الدخل والوضع الاجتماعي بتحسين الصحة. كلما اتسعت الفجوة بين أغنى الناس وأفقرهم، كلما اتسعت الفوارق في الصحة.
- **تعليم** - يرتبط انخفاض مستويات التعليم بسوء الحالة الصحية وزيادة التوتر وانخفاض الثقة بالنفس.
- **البيئة المادية** - المياه الصالحة للشرب والهواء النظيف وأماكن العمل الصحية والمنازل الآمنة والمجتمعات والطرق كلها تساهم في الصحة الجيدة.
- **شبكات الدعم الاجتماعي** - يرتبط الدعم الأكبر من العائلات والأصدقاء والمجتمعات بتحسين الصحة.
- **علم الوراثة** - يلعب الميراث دوراً في تحديد العمر والصحة والسلوك الشخصي ومهارات التأقلم واحتمال الإصابة بأمراض معينة.
- **الخدمات الصحية** - الوصول إلى الخدمات التي تمنع الأمراض وتعالجها واستخدامها يؤثر على الصحة
- **جنس** - يعاني الرجال والنساء من أنواع مختلفة من الأمراض في مختلف الأعمار.

Healthy People 2020

A society in which all people live long, healthy lives



Overarching Goals:

- Attain high-quality, longer lives free of preventable disease, disability, injury, and premature death.
- Achieve health equity, eliminate disparities, and improve the health of all groups.
- Create social and physical environments that promote good health for all.
- Promote quality of life, healthy development and healthy behaviors across all life stages.

النموذج: الأشخاص الأصحاء 2020.

من الولايات المتحدة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية مكتب الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة: مجموعة العمل الفيدرالية المشتركة بين الوكالات: رؤية ورسالة وأهداف الأشخاص الأصحاء 2020، بدون تاريخ، تم الاسترجاع من: <https://www.healthypeople.gov/sites/default/files/HP2020Framework.pdf>

العوامل الأساسية للوصول إلى صحة جيدة

من المعروف أن هناك عادات معينة ثابتة بين الأشخاص الناجحين والسعداء والمنتجين (والذين غالبًا ما يميلون لاحقًا إلى العيش لفترة أطول)، وكلها أسهل بكثير في تبنيها وممارستها مما قد تعتقد. وفيما يلي العوامل التي تشكل نمط الحياة الصحي:

(1) النشاط البدني واللياقة البدنية

لا تساعد ممارسة الرياضة والبقاء نشيطًا في الحفاظ على صحة جسمك فحسب (وخاصة قلبك ونظامك القلبي الوعائي)، ولكنه مفيد أيضًا لصحتك العقلية.

(2) علاقات وثيقة مع العائلة

إن تكوين علاقات وثيقة وجوهرية مع أفراد عائلتك والحفاظ عليها يمكن أن يساهم في صحتك من خلال منحك الشعور بالأمان والاستقرار.

(3) الحفاظ على نظام غذائي صحي

إن تناول الأطعمة التي تعزز الصحة الفسيولوجية سيجعلك تشعر ببساطة أفضل، مما سيجعلك سعيدًا أكثر من الاكتئاب.

(4) الحصول على قسط كاف من النوم

لقد ثبت أن الحصول على القدر المناسب من النوم المريح عالي الجودة على فترات زمنية مناسبة له تأثير ملموس ومباشر على صحتنا وسعادتنا.

(5) إبقاء التوتر عند الحد الأدنى

يسبب التوتر الزائد أضرارًا مزمنة لكل جزء منا، جسديًا وعقليًا، لذا فإن إيجاد طرق لتجنب التوتر وتخفيفه أمر بالغ الأهمية للمشاركة في نمط حياة صحي.

(6) الجنس والحميمة

إن الانخراط في علاقة رومانسية صحية مع شخص آخر يعد مساهمة مهمة في سعادتنا ورفاهيتنا العقلية.

(7) تنوع هواياتك

الأشخاص الذين يشاهدون التلفاز أو يتصفحون الإنترنت فقط في أوقات فراغهم يصابون بالمرض أكثر من الأشخاص الذين لديهم مجموعة متنوعة من الأنشطة التي يشاركون فيها مثل القراءة والكتابة والرسم والمشي لمسافات طويلة وما إلى ذلك.

(8) الحفاظ على حياة اجتماعية صحية

بالطبع، من الطبيعي أن يكون بعض الأشخاص انطوائيين والبعض الآخر منفتحين، ومع ذلك، فإن كونك منعزلاً للغاية وعدم وجود أي نوع من الحياة الاجتماعية يمكن أن يضر بسعادتك. يعد وجود صداقات خارج العمل والأسرة والحفاظ عليها جزءًا مهمًا حقًا مما يعنيه الحفاظ على نمط حياة صحي.

(9) لا للتبغ

وهذا المفهوم واضح لأسباب ندركها جميعًا جيدًا الآن. لا يوجد مكان للسجائر أو غيرها من منتجات التبغ المسببة للسرطان في نظام نمط الحياة الصحي.

الوقاية من الأمراض

الأمراض المعدية تسببها الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في مناطق أخرى الأشخاص أو الحيوانات أو البيئة وهي صغيرة جدًا بحيث لا يمكن رؤيتها. إذا لم تتواصل معهم، يمكنك الوقاية من العديد من الالتهابات والأمراض. تشمل الوقاية مجموعة واسعة من الأنشطة المعروفة باسم "التدخلات" التي تهدف إلى الحد من المخاطر أو التهديدات للصحة

فئات (مستويات) الوقاية

الوقاية الأولية

تهدف الوقاية الأولية إلى الوقاية من المرض أو الإصابة قبل حدوثها. ويتم ذلك عن طريق منع التعرض للمخاطر التي تسبب المرض أو الإصابة، وتغييرها

السلوكيات غير الصحية أو غير الآمنة التي يمكن أن تؤدي إلى المرض أو الإصابة، وزيادة مقاومة المرض أو الإصابة في حالة التعرض لها. **وتشمل الأمثلة:**

- التثقيف حول العادات الصحية والآمنة (على سبيل المثال، تناول الطعام بشكل جيد، وممارسة الرياضة بانتظام، وعدم التدخين)
- التحصين ضد الأمراض المعدية.

الوقاية الثانوية

تهدف الوقاية الثانوية إلى تقليل تأثير المرض أو الإصابة التي حدثت بالفعل. ويتم ذلك من خلال اكتشاف المرض أو الإصابة وعلاجها في أقرب وقت ممكن لإبطاء تقدمها، وتشجيع الاستراتيجيات الشخصية لمنع إعادة الإصابة أو تكرارها، وتنفيذ برامج لإعادة الأشخاص إلى صحتهم ووظيفتهم الأصلية لمنع المشاكل طويلة الأمد. **وتشمل الأمثلة:**

- اختبارات الفحص المنتظمة للكشف عن المرض في مراحله الأولى (على سبيل المثال تصوير الثدي بالأشعة السينية للكشف عن سرطان الثدي)
- تناول جرعات منخفضة من الأسبرين يوميًا و/أو اتباع نظام غذائي وبرامج تمارين رياضية لمنع المزيد من النوبات القلبية أو السكتات الدماغية

الوقاية الثلاثية

تهدف الوقاية الثلاثية إلى تخفيف تأثير المرض المستمر أو الإصابة التي لها آثار دائمة. ويتم ذلك من خلال مساعدة الأشخاص على إدارة المشاكل الصحية والإصابات طويلة الأمد والمعقدة في كثير من الأحيان (مثل الأمراض المزمنة والإعاقات الدائمة) من أجل تحسين قدرتهم على العمل ونوعية حياتهم ومتوسط العمر المتوقع قدر الإمكان. **وتشمل الأمثلة:**

- برامج إعادة تأهيل القلب أو السكتة الدماغية، وبرامج إدارة الأمراض المزمنة (على سبيل المثال مرض السكري، والتهاب المفاصل، والاكتهاب، وما إلى ذلك)
- مجموعات الدعم التي تسمح للأعضاء بمشاركة استراتيجيات العيش الكريم
- برامج إعادة التأهيل المهني لإعادة تدريب العمال على وظائف جديدة عندما يتعافون قدر الإمكان.

مبادئ الوقاية من العدوى

1. التطعيم واستخدام الأدوية بشكل صحيح

- حافظ على تحديث التطعيمات. اتبع التطعيمات الموصى بها للأطفال والبالغين والحيوانات الأليفة.

• استخدم المضادات الحيوية تمامًا كما هو موصوف. تناولها للدورة الكاملة التي وصفها لك طبيبك، ولا تعالج نفسك أبدًا بالمضادات الحيوية أو تشاركها مع العائلة أو الأصدقاء.

• أبلغ طبيبك عن أي عدوى تتفاقم بسرعة أو أي عدوى لا تتحسن بعد تناول المضاد الحيوي الموصوف لك.

• إذا كنت مسافرًا دوليًا، فاحصل على جميع التطعيمات الموصى بها، واستخدم الأدوية الوقائية أثناء السفر، وخاصة إلى المناطق الموبوءة بالمalaria.

2. حافظ على نظافتك

- اغسل يديك كثيرًا، خاصة خلال موسم البرد والأنفلونزا.
- كن على دراية بما تأكله، وقم بإعداد الأطعمة بعناية.

3. احم نفسك من حاملي الأمراض

- كن حذرًا من جميع الحيوانات البرية والمنزلية التي ليست مألوفة بالنسبة لك.
- بعد أي لدغة حيوان، قم بتنظيف الجلد بالماء والصابون، واطلب الرعاية الطبية على الفور.

- تجنب المناطق التي يوجد بها القراد.
- احم نفسك من البعوض.

4. لا تنشر المرض

- إذا كنت مريضًا بنزلة برد أو إنفلونزا، ابق في المنزل ولا تنشر الجراثيم.
- لا تستخدم الأدوية الوريدية أو تشارك الحقن.

فريق الرعاية الصحية

أهداف التعلم

- تعريف فريق الرعاية الصحية.
- اذكر عضو فريق الرعاية الصحية.
- ناقش دور عضو فريق الرعاية الصحية.
- وصف العوامل التي ترفع من كفاءة الفريق الصحي.

تعريف فريق الرعاية الصحية

إنها مجموعة المهنيين الذين يساهمون في رعاية المرضى وعلاجهم. قد يكون هناك ممرض ممارس بدلاً من الطبيب أو بالإضافة إليه. وفي حالات أخرى، قد يكون أخصائيو العلاج الطبيعي، وأخصائيو العلاج المهني، والعاملون الاجتماعيون جزءاً من الفريق.

عضو فريق الرعاية الصحية

الرعاية الصحية هي جهد جماعي. يعتبر كل مقدم رعاية صحية بمثابة عضو في الفريق وله دور خاص. بعض أعضاء الفريق هم أطباء أو فنيون يساعدون في تشخيص المرض. والبعض الآخر هم خبراء يعالجون الأمراض أو يهتمون بالاحتياجات الجسدية والعاطفية للمرضى.

يشمل أعضاء فريق الرعاية الصحية ما يلي:

- طبيب
- ممرضة مسجلة
- أخصائي علم الأمراض
- صيدلي
- أخصائي الأشعة
- أخصائية تغذية
- عامل اجتماعي
- زعيم روحي

دور عضو فريق الرعاية الصحية: -

> الأطباء:

الأطباء أو الأطباء هم الأعضاء الرئيسيون في فريق الرعاية الصحية. إنهم يستثمرون سنوات في التعليم والتدريب. قد يكونون أطباء رعاية أولية أو متخصصين

• **أطباء الرعاية الأولية:** يركز أطباء الرعاية الأولية بشكل أساسي على الرعاية الوقائية. ويشمل ذلك الفحص الروتيني والتطعيم والاستشارة.

• **متخصص:** حصل الأطباء المتخصصون على تدريب في مجالات صحية خاصة. على سبيل المثال، أطباء الأعصاب ، طبيب الغدد الصماء ، أورثو ، أطباء الأطفال .

➤ **الممرضة:**

إنهم يقدمون الرعاية ويديرون الأدوية وينسقون مع أعضاء فريق الرعاية الصحية الآخرين. لقد حصلوا على تدريب لمدة 3-4 سنوات اعتمادًا على تقدم الدورة. إنهم متخصصون ذوو مهارات عالية ويقدمون رعاية ممتازة للمريض.

➤ **أخصائي علم الأمراض:**

يقوم أخصائي علم الأمراض بإجراء فحوصات لسوائل وأنسجة الجسم في المختبر. أنها تساعد في الوصول إلى تشخيص معين للمريض.

➤ **الصيدلي:**

الصيدلي مسؤول عن التحقق من جودة الأدوية وسلامتها وصرفها. كما أنهم مسؤولون عن تخزين وصيانة مخزون الأدوية في بيئة الرعاية الصحية.

➤ **أخصائي الأشعة:**

يتخصص أخصائيو الأشعة في تقنيات التصوير مثل التصوير المقطعي والتصوير بالرنين المغناطيسي. يستخدمون مجموعة واسعة من الأدوات للحصول على صورة لعضو معين.

➤ **أخصائية تغذية:**

اختصاصي التغذية مسؤول عن تحديد الاحتياجات الغذائية ومراقبة إعداد الطعام والتحقق من الجودة وإعداد خطة النظام الغذائي للمريض.

➤ **الأخصائي الاجتماعي:**

ويقدمون اقتراحات بشأن الرعاية المنزلية، وتثقيف المريض حول حالات المرض والمرافق. معظم الأخصائيين الاجتماعيين في مجال الرعاية الصحية متورطون في أمراض عقلية.

➤ **القائد الروحي:**

يتم أيضًا تضمين القائد الروحي في فريق الرعاية الصحية لتلبية الاحتياجات الروحية للمريض. يلعب كل عضو في فريق الرعاية الصحية دوره في مجال خبرته الخاص.

العوامل التي ترفع من كفاءة الفريق الصحي.

➤ التغلب على العوائق التي تحول دون العمل الجماعي

إن بناء فرق رعاية صحية أفضل يتعلق جزئيًا بالتغلب على العوامل التعليمية والنفسية والتنظيمية التي تحبط جهودنا للتعاون مع بعضنا البعض. كيف نفعل هذا؟ وفيما يلي سبع استراتيجيات مجربة.

➤ تدريس استراتيجيات الاتصال الفعالة

إن تدريس أساليب الاتصال المنظمة، مثل عمليات تسليم 'SBAR'، يمكن أن يحسن نتائج المرضى.

➤ تدريب الفرق معًا

يجب على الفرق التي تعمل معًا أن تتدرب معًا، مما يمكنها من التحسن فهم أدوار ومساهمات بعضنا البعض.

➤ تدريب الفرق باستخدام المحاكاة

يؤدي استخدام المحاكاة بطريقة آمنة لممارسة التقنيات الجديدة والتدريب على المواقف التي تتم مواجهتها بشكل متكرر إلى تحسين التعاون وفعالية الفريق.

➤ تحديد الفرق الشاملة

أعد تعريف فريقك. بدلاً من رؤية أنفسكم كمجموعة من التخصصات، قم بإنشاء أهداف مشتركة ومتماسكة يتقاسمها جميع الأعضاء.

الفصل الثاني

الجزء (1): الرعاية الصحية الأولية

أهداف التعلم

في نهاية الفصل سيكون الطالب قادرًا على:-

- تعريف الرعاية الصحية الأولية (PHC).
- التعرف على مكون الرعاية الصحية الأولية.
- تحديد أهمية الرعاية الصحية الأولية.
- شرح مبادئ الرعاية الصحية الأولية.
- تصنيف أنواع فريق الرعاية الصحية الأولية.
- مناقشة دور الممرضة في الرعاية الصحية الأولية.

مقدمة:

يستحق جميع الناس، في كل مكان، الرعاية المناسبة، في مجتمعهم. هذه هي الفرضية الأساسية للرعاية الصحية الأولية. تلبي الرعاية الصحية الأولية غالبية الاحتياجات الصحية للشخص طوال حياته. ويشمل ذلك الصحة البدنية والعقلية والاجتماعية، وهو يركز على الإنسان وليس على المرض.

تعريف الرعاية الصحية الأولية:

الرعاية الصحية الأولية (PHC) هو نهج يشمل المجتمع بأكمله ويشمل تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض والعلاج وإعادة التأهيل والرعاية التلطيفية.



مكونات الرعاية الصحية الأولية:

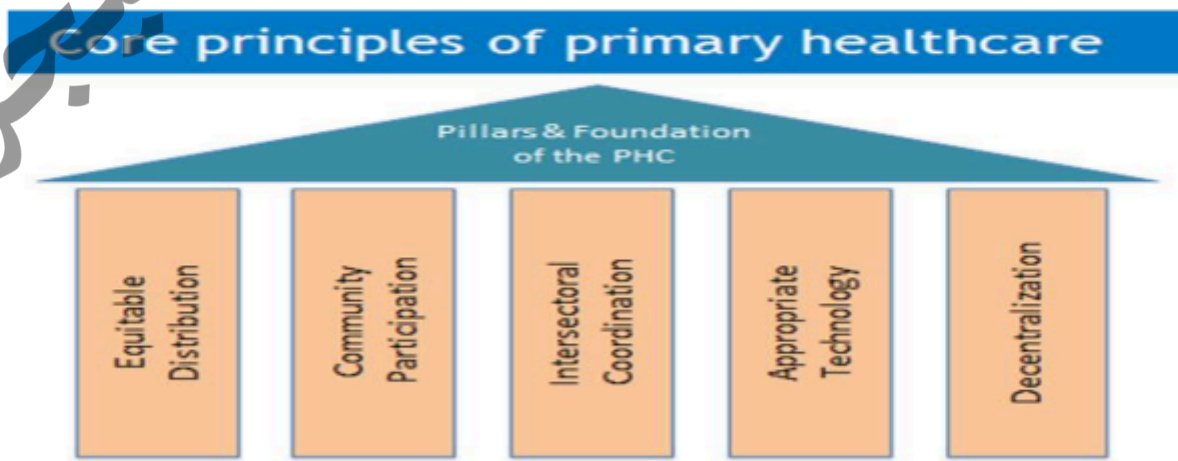
1. تلبية الاحتياجات الصحية للناس من خلال الرعاية الشاملة التعزيزية والحماية والوقائية والعلاجية والتأهيلية والتلطيفية طوال دورة الحياة؛
2. المعالجة المنهجية للمحددات الأوسع للصحة (بما في ذلك العوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية) من خلال سياسات وإجراءات مستندة إلى الأدلة في جميع القطاعات؛ و
3. تمكين الأفراد والأسر والمجتمعات من تحسين صحتهم.



أهمية الرعاية الصحية الأولية:

- الرعاية الصحية الأولية هي النهج الأكثر شمولاً وإنصافاً وفعالية من حيث التكلفة والكفاءة لتعزيز الصحة البدنية والعقلية للناس، فضلاً عن الرفاهية الاجتماعية.
- تعد الرعاية الصحية الأولية أيضاً أمراً بالغ الأهمية لجعل الأنظمة الصحية أكثر مرونة في مواجهة حالات الأزمات، وأكثر استباقية في اكتشاف العلامات المبكرة للأوبئة وأكثر استعداداً للتصرف مبكراً مثل كوفيد-19.

مبادئ الرعاية الصحية الأولية:



1- التوزيع العادل للموارد:

لجميع البشر الحق المتساوي في الصحة. ويعني التوزيع العادل أن الخدمات الصحية يجب أن يتقاسمها جميع الناس بالتساوي بغض النظر عن قدرتهم على الدفع؛ ويجب أن يحصل جميع الأشخاص - الأغنياء أو الفقراء، الريفيين أو الحضريين - على الخدمات الصحية.

2- المشاركة المجتمعية:

المشاركة المجتمعية هي العملية التي يتحمل من خلالها الأفراد والأسر والمجتمعات المسؤولية في تعزيز صحتهم ورفاهيتهم. وتؤكد استراتيجية الرعاية الصحية الأولية على أهمية المشاركة المجتمعية الكاملة، وخاصة في صنع القرارات الصحية.

3- التنسيق بين القطاعات:

تتطلب الرعاية الصحية الأولية دعم قطاعات أخرى مثل القطاعات المسؤولة عن الاقتصاد إن التنمية وتنقية المياه والصرف الصحي والاتصالات وحماية البيئة والتعليم كلها عوامل تساهم في الصحة.

4- تقنيات الرعاية الصحية المناسبة:

تشير التكنولوجيا المناسبة إلى استخدام معدات وتقنيات أرخص وصالحة علميًا ومقبولة. ▪ ومن الضروري أيضًا التأكد من أن التكنولوجيا هي:

▪ موثوقة وصالحة علميًا. ▪ تتكيف مع الاحتياجات المحلية. ▪ مقبولة لدى أفراد المجتمع. ▪ يمكن الوصول إليها وبأسعار معقولة من خلال الموارد المحلية.

5- اللامركزية:

تعمل الرعاية الصحية الأولية على تعزيز النهج الذي يركز على الناس في الرعاية الصحية، وهذا يشمل الخدمات الترويجية والوقائية والعلاجية والتأهيلية من خلال التعاون المجتمعي والمشاركة الكاملة.

عناصر الرعاية الصحية الأولية (PHC):

هناك ثمانية (8) عناصر للرعاية الصحية الأولية. هذه العناصر الثمانية هي تُعرف أيضًا باسم 'الرعاية الصحية الأساسية'.

Elements of Primary Health Care (PHC)	
E	Education about prevailing health problems and methods of preventing and controlling them
L	Prevention and control of locally endemic diseases
E	Provision of essential drugs
M	Maternal and child health care; including family planning
E	Expanded immunization against major infectious diseases
N	Promotion of food supply and proper nutrition
T	Appropriate treatment of common diseases and injuries
S	Adequate supply of safe water and basic sanitation

فريق الرعاية الصحية في الرعاية الصحية الأولية:

يمكن تحديد أنواع مختلفة من الفرق في أنظمة الرعاية الصحية:

- الفرق الأساسية: وهم يشاركون بشكل مباشر في رعاية المريض. ▪ وهم يتألفون عادة من قادة الفريق والأعضاء الذين يقدمون الرعاية المباشرة مثل الممرضات وأطباء الأسنان والصيدلة والأطباء والمساعدون ... إلخ.
- فرق التنسيق: المجموعة المسؤولة عن تنسيق المهام وإدارة الموارد للفرق الأساسية.
- فرق الطوارئ: تم تشكيلها للتعامل مع حالات الطوارئ أو الأحداث المحددة (على سبيل المثال فرق السكتة القلبية، وفرق الاستجابة للكوارث... إلخ).
- الفرق/الخدمات المساعدة: تدعم المجموعة الخدمات التي تسهل رعاية المرضى مثل عمال النظافة أو الموظفين المنزليين.
- خدمات الدعم والإدارة: أولئك الذين يقدمون مهام غير مباشرة- خدمات محددة في خدمة دعم مرافق الرعاية الصحية. ويشمل ذلك السكرتيرات والقيادة التنفيذية للوحدة أو المنشأة. يتمتع هذا الفريق بالمسؤولية على مدار 24 ساعة عن الأداء العام للمنظمة.

دور الممرضة في الرعاية الصحية الأولية:

يجب على الممرضات العاملات في مجال الرعاية الصحية الأولية أن يلعبن الأدوار التالية

1- الدفاع عن حقوق المرضى وثقتهم:

القدرة على تعزيز أحقية المرضى ' لضمان أفضل جودة للرعاية و تمكين المرضى من أن يصبحوا مشاركين فعالين في صحتهم.

2- التواصل الفعال:

القدرة على إقامة علاقة سريعة مع المرضى وأفراد أسرهم.

3- العمل الجماعي والقيادة:

القدرة على العمل بفعالية كعضو في فريق متعدد التخصصات يضم مقدمي الخدمات والمرضى وأفراد الأسرة لبناء علاقات عمل مثمرة ويركز على النتائج الصحية.

4- الرعاية التي تركز على الإنسان والممارسة السريرية:

القدرة على تهيئة الظروف لتوفير خدمات منسقة/ متكاملة تركز على احتياجات المرضى وأسرهم وقيمهم وتفضيلاتهم.

5- التعلم والبحث المستمر:

القدرة على إظهار الممارسة التأملية، بناءً على أفضل الأدلة المتاحة وتقييم الخدمات المقدمة وتحسينها باستمرار.

الجزء (2): صحة الأم والطفل

أهداف التعلم

في نهاية الفصل سيكون الطالب قادرًا على:-

- تعريف صحة الأم وصحة الطفل (تصنيف الطفولة).
- التعرف على العلاقة بين صحة الأم وصحة الطفل.
- تحديد خدمات الرعاية الصحية للأم والطفل (MCH).
- قائمة أهداف خدمات صحة الأم والطفل.
- التعرف على المكون الرئيسي لخدمة صحة الأم والطفل.
- اشرح المؤشر المشترك لخدمة صحة الأم والطفل.
- مناقشة الشراكة لتحسين صحة الأم والطفل في مصر.
- إظهار دور الممرضات في رعاية صحة الأم والطفل.

مقدمة:

إن صحة الإنسان في كل مرحلة من مراحل حياته تؤثر على صحته في مراحل أخرى، كما يمكن أن يكون لها آثار تراكمية على الجيل التالي. النساء اللاتي يظنن بصحة جيدة أثناء الحمل وبعد الولادة أكثر عرضة للبقاء بصحة جيدة في وقت لاحق من الحياة والحصول على نتائج ولادة أفضل، مما يؤثر على الرضاعة والطفولة والبلوغ.

صحة الأم والطفل:

تشير صحة الأم والطفل (MCH) إلى صحة الأمهات والرضع والأطفال والمراهقين. ويشير أيضًا إلى مهنة في مجال الصحة العامة ملتزمة بتعزيز الحالة الصحية والتحديات المستقبلية لهذه الفئة الضعيفة من السكان.

تعريف صحة الأم:

تشير صحة الأم إلى صحة المرأة قبل وأثناء الحمل وعند الولادة وأثناء فترة ما بعد الولادة.

تعريف صحة الطفل:

صحة الأطفال هي مدى قدرة الأطفال الأفراد أو مجموعات الأطفال على قادرون أو قادرون على (أ) تطوير وتحقيق إمكاناتهم، (ب) تلبية احتياجاتهم، و (ج) تطوير القدرات التي تسمح لهم بالتفاعل بنجاح مع بيئاتهم البيولوجية والمادية والاجتماعية.

« مراحل نمو الطفولة:



الطفولة المبكرة:

تتبع مرحلة الطفولة المبكرة مرحلة الطفولة وتبدأ بالطفولة الصغيرة عندما يبدأ الطفل في التحدث أو اتخاذ الخطوات بشكل مستقل، وتستمر الطفولة المبكرة حتى سن 6 أو 7 سنوات تقريبًا.

الطفولة الوسطى:

تبدأ مرحلة الطفولة المتوسطة في حوالي سن السابعة، أي ما يقرب من سن المدرسة الابتدائية. برزخ وينتهي الأمر بالبلوغ (حوالي سن 12 أو 13 عامًا)، والذي يمثل عادةً بداية مرحلة المراهقة.

ما بعد الطفولة (المراهقة):

عادة ما يتم تحديد المراهقة على أنها تقع بين بداية البلوغ والبلوغ القانوني: وتتوافق في الغالب مع سنوات المراهقة (13-19). ومع ذلك، فإن البلوغ يبدأ عادة قبل سنوات المراهقة.

العلاقة بين صحة الأم وصحة الطفل:

يعد سوء صحة الأم وعدم كفاية تغذية الأم من المحددات الرئيسية لصحة الطفل. وتشمل التأثيرات الرئيسية ما يلي: انخفاض الوزن عند الولادة، زيادة الوزن/ نقص الوزن وفقر الدم والالتهابات واضطرابات المناعة وزيادة خطر إصابة الطفل بالسمنة والأمراض المزمنة ذات الصلة كشخص بالغ.



خدمات صحة الأم والطفل:

خدمات صحة الأم والطفل تُعرف بأنها مرافق تعزيزية أو وقائية أو علاجية أو إعادة تأهيلية أو رعاية للأم والطفل.

• أهداف خدمات صحة الأم والطفل:

- 1 - الحد من الوفيات والأمراض بين الأمهات والأطفال حديثي الولادة والرضع والأطفال
- 2 - تعزيز الصحة الإنجابية
- 3 - تعزيز النمو الجسدي والنفسي للطفل والمراهق داخل الأسرة الهدف النهائي لخدمة صحة الأم والطفل هو الصحة مدى الحياة.

مكون خدمات صحة الأم والطفل (MCH) في مصر:

- 1- رعاية ما قبل الولادة وما بعد الولادة.
- 2- رعاية صحة الطفل والتحصين
- 3- تنظيم الأسرة
- 4- الصحة الإنجابية

تركز برامج صحة الأم والطفل على القضايا الصحية المتعلقة بالنساء والأطفال والأسر، مثل الوصول إلى الرعاية الموصى بها قبل الولادة ورعاية صحة الطفل، والوقاية من وفيات الرضع والأمهات، والصحة العقلية للأم والطفل، وفحص الأطفال حديثي الولادة، وتحسينات الأطفال، وتغذية الأطفال، والخدمات المقدمة للأطفال ذوي احتياجات الرعاية الصحية الخاصة.

مؤشرات صحة الأم والطفل:

مؤشرات صحة الأم:

1- نسبة وفيات الأمهات

نسبة وفيات الأمهات (MMR) هي عدد النساء اللاتي يموتن بسببها الأسباب المتعلقة بالحمل أثناء الحمل أو خلال 42 يومًا من إنهاء الحمل لكل 100 ألف ولادة حية. **معظم وفيات الأمهات تنتج عن:** نزيف ما بعد الولادة، أمراض ارتفاع ضغط الدم، والنزيف قبل الولادة، والإنتان.

2- تغطية رعاية ما قبل الولادة:

يمكن الوقاية من العديد من المشاكل الصحية لدى النساء الحوامل واكتشافها وعلاجها أثناء زيارات الرعاية السابقة للولادة مع العاملين الصحيين المدربين.

3- الولادات الماهرة:

ويرتبط هذا المؤشر ارتباطاً مباشراً بعملية الولادة لدى المرأة الحامل ومعظم الأمهات الموت مثل من المتوقع أن يحدث هذا في هذه المرحلة. زادت عمليات الولادة بمساعدة طبية بشكل كبير.

4- تغطية رعاية ما بعد الولادة:

وبما أن ما يصل إلى 50 بالمائة من وفيات الأمهات تحدث بعد الولادة، فيجب على القابلة أو القابلة التقليدية المدربة والخاضعة للإشراف (TBA) زيارة جميع الأمهات في أقرب وقت ممكن خلال أول 24-48 ساعة بعد الولادة.

5- استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة:

يشير المسح الديموغرافي والصحي المصري لعام 2014 (EDHS) إلى أن حوالي 59 بالمائة من النساء المتزوجات حالياً في مصر يستخدمن وسائل منع الحمل. ال الطرق الأكثر استخداماً هي اللولب وحبوب منع الحمل والحقن.

مؤشرات صحة الطفل:

1- معدل وفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة:

معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة هو احتمال وفاة طفل حديث الولادة لكل 1000 طفل يموت قبل بلوغه سن الخامسة.

2- تغطية التطعيم:

يجب أن يتلقى الأطفال التطعيم الكامل ضد مرض السيل والحصبة، الخناق والسعال الديكي والتيتانوس وشلل الأطفال.

3- الرضاعة الطبيعية الحصرية:

توصية الصحة العامة العالمية هي أن الرضع يجب أن يكونوا حصرياً الرضاعة الطبيعية خلال الأشهر الستة الأولى من الحياة، بدءاً من النصف ساعة الأولى بعد الولادة. في مصر، يوضح المسح الديموغرافي والصحي لعام 2014 أن الرضاعة الطبيعية الحصرية شائعة ولكنها ليست كذلك عالمي في مرحلة الطفولة المبكرة جداً.

4- سوء التغذية لدى الأطفال:

ويعزى ثلثا وفيات الأطفال إلى سوء التغذية. معدلات سوء التغذية ولا تزال مرتفعة خاصة بين الأطفال دون سن الخامسة.

الشراكة لتحسين صحة الأم والطفل في مصر:

لقد حققت مصر تقدماً إيجابياً في مجال صحة الأم والطفل على مدى العشرين عاماً الماضية، وتقترب مصر من تحقيق هدفها الإنمائي المستدام (الهدف الثالث): ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهية للجميع في جميع الأعمار. > الأهداف:

• بحلول عام 2030، خفض معدل وفيات الأمهات على مستوى العالم إلى أقل من 70 لكل 100 ألف ولادة حية.

• بحلول عام 2030، ضمان حصول الجميع على خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة والمعلومات والتعليم، وإدماج الصحة الإنجابية في الاستراتيجيات والبرامج الوطنية.

• بحلول عام 2030، وضع حد للوفيات التي يمكن الوقاية منها بين الأطفال حديثي الولادة والأطفال دون سن الخامسة، مع سعي جميع البلدان إلى خفض معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة إلى ما لا يقل عن 12 لكل 1000 ولادة حية ومعدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى ما لا يقل عن 25 لكل 1000 المواليد الأحياء.

دور الممرضة في رعاية صحة الأم والطفل:

• مقدم الخدمة

- توفير الرعاية قبل الولادة.
- مراقبة نمو الجنين ورفاهيته.
- فحص التكوينات السيئة والتشوهات الخلقية والانحرافات الأخرى.
- مكملات الفيتامينات والعناصر الغذائية الدقيقة اللازمة.
- تعزيز ممارسات التسليم الجيدة.
- تعزيز الرضاعة الطبيعية والترابط الأمومي.
- تعزيز الرعاية المثلى للمواليد الجدد.
- ضمان خدمات التحصين المناسبة.
- النمو الدوري والتطور ومراقبة حجر الميل.

• خدمات للأمهات

- تقييم صعوبات التغذية.
- تعزيز مكملات الحديد والكالسيوم.
- مراقبة وتعزيز النظام الغذائي المتوازن والعادات الغذائية الجيدة.
- مراقبة الاكتئاب بعد الولادة.
- تعزيز اعتماد ممارسات منع الحمل وتنظيم الأسرة.
- تثقيف الأم حول أهمية تربية الطفل وممارسات الرعاية الذاتية بما في ذلك النظام الغذائي وممارسة الرياضة والنوم.

• الدور كمسؤول:

- العمل كمزود معلومات لصانعي السياسات فيما يتعلق بخدمات صحة الأم والطفل.
- العمل كحلقة وصل مع الحكومة والمجتمع والمنظمات غير الحكومية في تنظيم وتنفيذ خدمات صحة الأم والطفل.
- تطوير شبكة الاستشارة والمساعدة في صحة الأم والطفل.

• تربيوي

- تنظيم برامج تدريبية للعاملين في مجال الرعاية الصحية.
- إجراء ورش عمل ومؤتمرات تتعلق برعاية صحة الأم والطفل وتوعية المجتمع والعاملين في مجال الرعاية الصحية.
- تصميم مواد التثقيف الصحي حول خدمات صحة الأم والطفل.

• الباحث

- تحديد المجالات القابلة للبحث في صحة الأم والطفل وإجراء البحوث.
- التنسيق والتواصل بشأن الأنشطة البحثية.
- تصميم النماذج بناءً على نتائج الأبحاث.

الطلاب' التقييم الذاتي

أ. أي فريق مسؤول عن التعامل مع حالات الطوارئ أو الأحداث المحددة
أ. الفرق الأساسية ب. فرق التنسيق ج. فرق الطوارئ د. الفرق/الخدمات
المساعدة

ب. تمثل جميع المؤشرات التالية مؤشرات صحة الطفل، باستثناء:
أ. معدل وفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة ب. تغطية التطعيم ج.
الولادات الماهرة د. الرضاعة الطبيعية الحصرية

ج. معظم وفيات الأمهات تنتج عن:
أ. نزيف ما بعد الولادة ب. داء السكري ج. انخفاض الوزن عند الولادة د.
التشوهات الخلقية.

د. مناقشة دور ممرضة المجتمع في رعاية صحة الأم والطفل.

الفصل الثالث

خدمات الصحة العامة

أهداف التعلم

في نهاية الفصل سيكون الطالب قادرًا على:-

1. تحديد خدمات الصحة المجتمعية

2. مناقشة الرعاية الصحية المنزلية

3. شرح الرعاية الصحية للأسرة

4. وصف الرعاية الصحية المدرسية

مقدمة:

تغطي خدمات الصحة العامة مجموعة واسعة من الخدمات وتوفر الرعاية للناس منذ الولادة وحتى نهاية حياتهم. تلعب فرق الصحة المجتمعية دورًا حيويًا في دعم الأشخاص الذين يعانون من احتياجات صحية ورعاية معقدة للعيش بشكل مستقل في منازلهم لأطول فترة ممكنة. وتشمل الخدمات أيضًا خدمات تعزيز الصحة مثل خدمات الصحة المدرسية وخدمات الزيارة الصحية.

تعريف خدمات الصحة العامة

يتم تقديم الخدمات في مجموعة واسعة من الأماكن – بما في ذلك منازل الأشخاص وكذلك في العيادات المجتمعية والمراكز المجتمعية والمدارس.

وظائف الصحة العامة الشاملة

- زيارة صحية
- التمريض المدرسي
- خدمات الصحة العائلية والجنسية

الرعاية الصحية المنزلية

مقدمة

توفر صحة المجتمع في المنزل العلاج والمساعدة للمرضى الذين يتعافون أو المصابين بأمراض مزمنة أو معاقين - وهم مرتاحون في منازلهم. تشمل خدمات الرعاية المنزلية لدينا برامج متخصصة، والوقاية والحفاظ على الصحة على المدى القصير والطويل، ومجموعة واسعة من الخدمات بدءًا من التمريض عالي التقنية وحتى رعاية المساعدين الصحيين المنزليين الأساسيين.

تعريف الرعاية الصحية المنزلية

➤ أربع وجهات نظر مختلفة

رسمي

يتم تقديم الخدمات للأفراد وأسرهم في مكان إقامتهم الغرض من تعزيز الصحة أو الحفاظ عليها أو استعادتها أو تقليل آثار المرض والإعاقة.

مريض

يتم تقديم الرعاية الماهرة والرحيمة على أساس فردي في محيط المنزل المريح والمألوف.

عائلة

إنها وسيلة للحفاظ على تماسك الأسرة كوحدة فعالة ومتكاملة.

مزود

تواجه جميع التخصصات المعنية تحديًا يتمثل في تقديم رعاية ممتازة في ظروف ومحيط أقل من ممتاز في كثير من الأحيان.

التمريض الصحي المنزلي

• تتيح خدمات التمريض الصحي المنزلي للأفراد من جميع الأعمار البقاء في راحة وأمان منازلهم أثناء تلقي الرعاية الصحية.

مكونات خدمات الرعاية الصحية المنزلية:

• قد تشمل الخدمات التمريض الماهر، والعلاج الطبيعي، وعلاج النطق واللغة، والعلاج المهني، والخدمات الاجتماعية، والعلاج الوريدي، والدعم الغذائي، والعلاج المنزلي. المساعد الصحي، والعلاج التنفسي، وشراء الإمدادات والمعدات الطبية، ورعاية ربة المنزل والرفيقة.



التمريض الماهر:

يتمتع الممرضون المسجلون المهرة بالخبرة والموارد اللازمة لتوفير عدد من الخدمات، بما في ذلك:

- العلاج بالتسريب والحقن
- رسومات المختبر
- صيانة الخط المركزي والميناء
- العناية بالجروح
- تغذية الأنبوب
- العناية بالفجرة
- علاج الأمراض الجلدية
- إدارة المرض

العلاج الطبيعي:

هناك تقنيات علاجية محددة لا يعرفها إلا المعالج الطبيعي المدرب. معظم يفضل المرضى إجراء جلسات العلاج الطبيعي في خصوصية منازلهم. مع المعالج الطبيعي، سيري المرضى العديد من الفوائد، بما في ذلك:

- تحسين القدرة على التحمل
- إعادة التأهيل بعد الجراحة
- التدريب المعزز على المشي (تقنية المشي)
- زيادة القدرة على الحركة والقوة

العلاج المهني:

يعد المعالج المهني بمثابة فائدة دعم مثالية لمقدم الرعاية الجديد أو الأسرة عضو قد لا يعرف ما يحتاجه مريضه. على سبيل المثال، قد يكون هناك أمان المخاطر التي يمكن للمعالج المهني المساعدة في تحديدها. وجود مهنة يمكن للمعالج الذي يأتي إلى منزلك أن يساعدك بهذه الطرق:

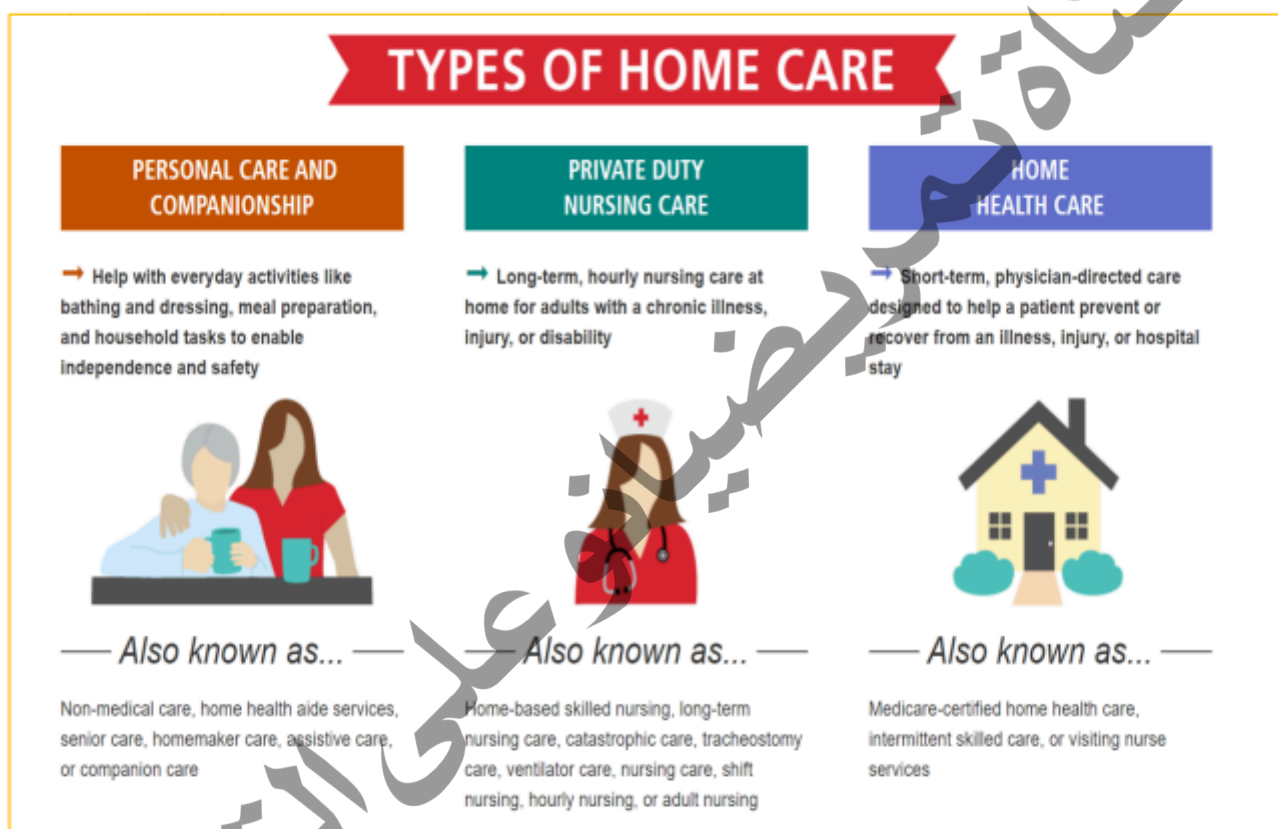
- تحسين قدرة المريض على أداء الرعاية الذاتية اليومية
- استعادة الاستقلال في المنزل
- تقديم توصيات بشأن المعدات التكميلية للمنزل

علاج النطق

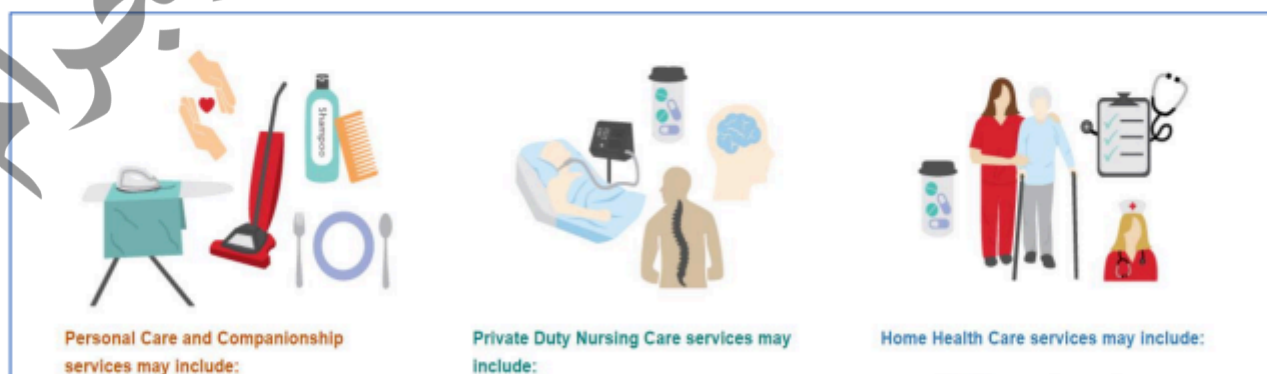
معالج النطق مهم لاستعادة القدرة على الكلام وتحسينها
القصور المعرفي. غالبًا ما يكون علاج النطق ضروريًا بعد السكتة الدماغية. مع عادي
الجلسات، سوف يرى المرضى:

- تحسين القدرة على الكلام
- تحسن في البلع
- تحسن في القصور الإدراكي

أنواع الرعاية المنزلية:



أمثلة على خدمات الرعاية



قد تشمل خدمات العناية الشخصية والرفقة ما يلي:

- المساعدة في العناية الذاتية، مثل العناية الشخصية، والاستحمام، وارتداء الملابس، واستخدام المرحاض. ▪ تمكين السلامة في المنزل من خلال المساعدة في المشي والنقل (على سبيل المثال، من السرير إلى الكرسي المتحرك، ومن الكرسي المتحرك إلى المرحاض)، والوقاية من السقوط
- المساعدة في تخطيط الوجبات وإعدادها، والتدبير المنزلي الخفيف، وغسيل الملابس، والمهمات، والتذكير بالأدوية، ومرافقة المواعيد
- الرفقة وممارسة الهوايات والأنشطة ▪ الإشراف على شخص مصاب بالخرف أو مرض الزهايمر.

قد تشمل خدمات رعاية التمريض الخاصة ما يلي:

- رعاية أمراض مثل إصابات الدماغ المؤلمة أو إصابة النخاع الشوكي. ▪ العناية بجهاز التنفس الصناعي ▪ رعاية القصبة الهوائية ▪ مراقبة العلامات الحيوية ▪ إعطاء الأدوية
- العناية بفقر المعدة/فقر المعدة ▪ العناية بأنبوب التغذية ▪ رعاية القسطرة

قد تشمل خدمات الرعاية الصحية المنزلية ما يلي:

- خدمات التمريض قصيرة المدى ▪ العلاج الطبيعي ▪ العلاج المهني ▪ أمراض النطق واللغة ▪ العمل الاجتماعي الطبي ▪ خدمات المساعدة الصحية المنزلية

زيارة منزلية

مقدمة:

تعد الزيارة المنزلية أحد الأجزاء الأساسية للخدمات الصحية المجتمعية لأن معظم الأشخاص يتواجدون في المنزل. تلبى الزيارة المنزلية احتياجات الفرد والأسرة والمجتمع بشكل عام فيما يتعلق بخدمة التمريض والاستشارات الصحية. تعتبر الزيارة المنزلية بمثابة العمود الفقري لخدمة الصحة المجتمعية.

الزيارة المنزلية هي اتصال عائلي - ممرضة يسمح للعامل الصحي بتقييم الوضع المنزلي والعائلي من أجل تقديم الرعاية التمريضية اللازمة والأنشطة المتعلقة بالصحة. تتطلب الخدمات في المنزل مهارات تقنية ومعرفة بالتدابير الوقائية والعلاجية والقدرة على التدريس والحكم والفهم الكامل للعلاقات الإنسانية.

تعريف:

➤ يتم تعريف الزيارة المنزلية على أنها عملية تقديم الرعاية التمريضية للمرضى على أبواب منازلهم. فهو يتطلب المهارات التقنية، والحيلة، والحكم، والعلاقات.

➤ يتم تعريفه على أنه تقديم الخدمات للأسرة على عتبة بابها للحفاظ على الصحة وتقليل الوفيات والأمراض في الأسرة.

أغراض الزيارة المنزلية:

1. رعاية المرضى والأم بعد الولادة وطفلها حديث الولادة بهدف تعليم أحد أفراد الأسرة المسؤولين كيفية تقديم الرعاية اللاحقة.
2. تقييم الحالة المعيشية للمريض وأسرته وممارساتهم الصحية من أجل توفير التعليم الصحي المناسب.
3. إعطاء تعاليم صحية فيما يتعلق بالوقاية من الأمراض ومكافحتها.
4. إقامة علاقة وثيقة بين الهيئات الصحية والجمهور من أجل تعزيز الصحة.
5. الاستفادة من نظام الإحالة المتبادلة وتعزيز الاستفادة من الخدمات المجتمعية.

مبادئ الزيارة المنزلية

1. يجب أن يكون للزيارة المنزلية غرض أو هدف.
2. يجب أن يستفيد التخطيط لزيارة منزلية من جميع المعلومات المتاحة حول المريض وعائلته من خلال السجلات العائلية.
3. مراعاة وإعطاء الأولوية للاحتياجات الأساسية للفرد وأسرته.
4. يجب أن يشمل تخطيط وتقديم الرعاية الفرد وأسرته.
5. يجب أن تكون الخطة مرنة.

المبادئ التوجيهية التي ينبغي مراعاتها فيما يتعلق بتواتر الزيارات المنزلية

- على أساس الحاجة: يجب التخطيط للزيارات المنزلية وإجرائها بناءً على ما تم تحديده احتياجات الناس
- على أساس الأولوية: يجب أن تتناول الزيارة المنزلية المشكلة الموجودة في الأسرة. برزخ قد تكون خدمات صحة الأم والطفل أو فحص ما قبل الولادة
- انتظام: التخطيط لبرامج الزيارات المنزلية المنتظمة بناءً على احتياجات الأسرة. برزخ ينبغي أن يتم إجراؤها على فترات منتظمة
- المرونة: يجب على ممرضة الصحة المجتمعية أن تتبنى نهجًا مرئيًا يعتمد على الظروف السائدة في المنزل
- على أساس علمي: التأكد من السلامة العلمية للمواضيع المستخدمة مناقشة. استخدام المهارات التقنية يشمل غسل اليدين والتفتيش
- على أساس التحليل: جمع الحقائق حول المنزل والمريض والبيئة و إجراء تحليل موضوعي للحقائق كخطوة أولية لزيارة المنزل
- تطوير العلاقة: العمل مع الشخص وخطة الأسرة بشكل مشترك. بيت تساعد الزيارة على إقامة علاقة عمل جيدة في الأسرة
- الحساسية: يجب أن تكون ممرضة صحة المجتمع حساسة لمشاعر الأشخاص والاحتياجات في وقت الزيارة. استمع للعائلة وافهم الآخر وجهة نظر الشخص
- التقييم: تقييم جودة الرعاية أهم من عدد المنازل الزيارات. من الضروري تقييم الزيارات المنزلية من وقت لآخر

مراحل الزيارة المنزلية:

1. المرحلة الأولى: ينبغي لممرضة صحة المجتمع
 - جمع المعلومات من السجلات السريرية وغيرها قبل التخطيط للزيارة.
 - قم بالتقييم أو الملاحظة وتدوين ملاحظة في الزيارة الأولى

- تقديم وإقامة علاقة ودية باستخدام لغة بسيطة.
- تقييم الحالة المادية والبيئية، والخلفية الثقافية للأسرة، مهنة ودخل أفراد الأسرة والعمر والعوامل التعليمية و العوامل النفسية المؤثرة

مرحلة العمل: ينبغي للممرضة

- استخدام مهارات الاتصال الفعالة لديهم لتنفيذ عملية التمريض.
- ممارسة مجموعة متنوعة من الأدوار عند إجراء المقابلات في رعاية المرضى.
- قم بدور المتعاون، المستشار، المنسق المشارك، الوقاية من المرض، مروج للصحة ومعلم صحي وعالم أوبئة، ويتخذ خطوات لتحقيق ذلك تنفيذ عملية التمريض
- يقدم الرعاية التمريضية، مثل قياس درجة الحرارة والفحص البدني و ارتداء الملابس، وما إلى ذلك، والعرض والتدريس، على سبيل المثال تعليم الأنسولين ذاتيًا إداري. تقوم بإجراء التشخيص ووضع خطة رعاية تمريضية مؤقتة بناءً على تحديد الأولويات

مرحلة الإنهاء:

- تم تحقيق أهداف الممرضة والمريض، وتم استعادة الصحة وأصبح المريض قادرًا على العمل بدون أفعال.
- تسجل الممرضة الأحداث المهمة في الأسرة وتبلغ عن مشاكلها العائلة. إن تقييم الزيارة المنزلية عملية مستمرة.

خطوات

1. تحية للمريض وتقديم نفسك.
2. اذكر الغرض من الزيارة
3. مراقبة المريض وتحديد احتياجاته الصحية.
4. ضع الكيس في مكان مناسب ثم انتقل إلى تنفيذ تقنية الكيس.
5. أداء الرعاية التمريضية اللازمة وإعطاء التعاليم الصحية.
6. سجل جميع التواريخ المهمة والملاحظات والرعاية المقدمة.
7. حدد موعدًا لزيارة العودة.

مزايا الزيارة المنزلية

- يمكن للممرضة مراقبة أجواء المنزل والعائلة بشكل مباشر
- يمكن للممرضة مراقبة الرعاية المقدمة للمريض من قبل أفراد الأسرة بشكل مباشر
- من الممكن اكتشاف مشاكل صحية جديدة
- سيكون أفراد الأسرة أكثر استرخاءً في محيطهم الخاص
- تكتسب الأسرة الثقة وتشعر بضرورة إزالة شكوكها
- وهذا يساعد على تطبيق المعرفة والمهارات المكتسبة في المنازل المساعدة و حل المشاكل الصحية للأفراد والأسرة.

مساوئ الزيارات المنزلية:

- الزيارات المنزلية تستغرق وقتاً طويلاً؛ مطلوب وقت السفر للوصول إلى الأشخاص بحاجة إلى رعاية.
- لا يوجد وصول سهل إلى معدات الطوارئ أو التشاور مع الآخرين
- المهنيين الصحيين إذا لزم الأمر.
- قد تثير الزيارات المنزلية مشكلات تتعلق بالسلامة الشخصية للممرضة في بعض الحالات البيئات المجتمعية أو العائلية.
- تتمتع الممرضة بقدر أقل من التحكم في بيئة الرعاية (على سبيل المثال، النظافة والوضوء الخصوصية، أو الانحرافات).

حقيبة ممرضة صحة المجتمع:

ال **حقيبة الصحة العامة** هي معدات أساسية لا غنى عنها لممرضة الصحة العامة والتي يتعين عليها حملها معها أثناء زياراتها المنزلية. ويحتوي على الأدوية الأساسية والمواد اللازمة لتقديم الرعاية.

ال **تقنية الحقيبة** هي أداة تمكن الممرضة من خلالها، أثناء زيارتها، من إجراء عملية التمريض بسهولة ومهارة، لتوفير الوقت والجهد بهدف تقديم رعاية ترميضية فعالة للعملاء.

مبادئ

- إن تنفيذ تقنية الكيس سوف يقلل، إن لم يكن يمنع، انتشار أي عدوى.
- فهو يوفر الوقت والجهد في أداء الإجراءات التمريضية.

▪ يمكن تنفيذ تقنية الكيس بعدة طرق اعتمادًا على سياسة الوكالة، أو الوضع المنزلي، أو طالما تم مراعاة مبادئ تجنب انتقال العدوى دائمًا.

محتويات

وفيما يلي محتويات حقيبة ممرضة الصحة العامة:

1. زوج من القفازات المعقمة
• مقياس الطفل
• مصباح الكحول
2. أنابيب اختبار/حاملات أنابيب اختبار
• حلول:
• بيتادين، 70% كحول، محلول زيفيران،
بيروكسيد الهيدروجين
• مرهم العيون
• حمض الأسيتيك
• حل بنديكت
*يتم حمل جهاز قياس ضغط الدم وسماعة الطبيب
بشكل منفصل ولا يتم وضعهما في الحقيبة أبدًا.

• بطانة ورقية/ورق إضافي لصنع أكياس النفايات
• بطانة بلاستيكية/كتانية
• منثر/منشفة يد
• الصابون في طبق الصابون
• موازين الحرارة (الفموية والمستقيمية)
2. زوج من المقصات (الجراحية والضمادات)
2. زوج من الملقط (منحني ومستقيم)
• محاقن يمكن التخلص منها مع الإبر
• إبر تحت الجلد
• ضمادة معقمة / كرات قطنية
• مشبك الحبل
• قياس الجص/الشريط ذو المسام الدقيقة

النقاط التي يجب مراعاتها:

1. يجب أن تحتوي الحقيبة على جميع المواد واللوازم والمعدات اللازمة التي سيتم استخدامها لتلبية احتياجات الطوارئ
2. ينبغي تنظيف الحقيبة ومحتوياتها بشكل متكرر، واستبدال المستلزمات وجعلها جاهزة للاستخدام في أي وقت.
3. يجب حماية الحقيبة ومحتوياتها بشكل جيد من ملامسة أي مادة في منزل المريض.
4. اعتبر الحقيبة ومحتوياتها نظيفة ومعقمة، في حين أن الأشياء التي تنتمي إلى المرضى قدرون وملوثون.
5. يجب أن يكون ترتيب محتويات الحقيبة هو الأكثر ملاءمة للمستخدم، لتسهيل الكفاءة وتجنب الارتباك.

مقدمة:

تعتبر خدمات الرعاية التمريضية لصحة الأسرة في المجتمع هي النقطة المحورية للخدمات الصحية. إنها رعاية خاصة تُعطى لأفراد الأسرة لتعزيز صحتهم، والوقاية من المشاكل الصحية، ولصالح الأسرة.

تعريف:

العائلة: الوحدة الأساسية في المجتمع هي شخصان أو أكثر مرتبطان بالولادة أو الزواج أو التبني ويقيمون معًا في الأسرة، وتتكون من جميع القوى المحيطة بها. إنهم يشكلون منزلًا واحدًا، ويتفاعلون مع بعضهم البعض في أدوارهم العائلية الخاصة، ويخلقون ثقافة مشتركة ويحافظون عليها.

"**خدمات صحة الأسرة** يمكن تعريفها بأنها امتلاك المهارات والموارد اللازمة للقيام بذلك مهام تنمية الأسرة. إنها رعاية خاصة تُعطى لأفراد الأسرة لتعزيز قدراتهم الصحة، والوقاية من المشاكل الصحية، ولصالح الأسرة."

التمريض العائلي: هو جزء من الرعاية الأولية المقدمة للمرضى من جميع الأعمار، من صحة الطفل إلى طب الشيخوخة. يساعد هذا في تعزيز العلاقة القوية بين الرعاية الصحية مقدم الخدمة والمريض. التمريض العائلي ليس رعاية تركز بشكل كبير على المريض كما هو الحال بالنسبة لرعاية وحدة الأسرة.

غرض:

1. خفض معدل وفيات الأمهات والأمراض ووفيات الرضع.
2. المباشرة بين ولادات الأطفال.
3. حل مشكلة سوء التغذية في الأسرة.
4. التثقيف الصحي

نطاقات:

أهداف الصحة الفردية والمجتمعية والنمو في الصحة الوطنية
يمكن تحقيق المستوى من خلال خدمات الصحة العائلية:

1. الصحة الإنجابية
2. صحة الأطفال
3. صحة المراهقين

4. الصحة النفسية
5. قضايا النوع الاجتماعي
6. الشيخوخة

مبادئ:

- إقامة علاقة مهنية جيدة مع الأسرة
- معرفة الحقائق الأساسية الحجم والمهنة، مثل قواعد العادات، الطقوس والتعليم
- تحديد المشاكل وألويتها
- الخدمات والدعم المبني على الاحتياجات للأسرة
- مناقشة المشكلة مع الأسرة والحل الممكن
- تشجيع الأسرة على الاعتماد على نفسها لتلبية احتياجاتها
- يجب أن تكون الخدمات الصحية مستقلة عن الجنس والعمر والدخل والدين
- إشراك أفراد الأسرة

خصائص الأسرة الصحية:

1. توجد عملية تسهيلية للتفاعل بين أفراد الأسرة.
2. يتم تعزيز تنمية الأعضاء الفردية.
3. يتم تنظيم علاقات الأدوار بشكل فعال.
4. يتم إجراء محاولات نشطة للتعامل مع المشاكل.
5. هناك بيئة منزلية وأسلوب حياة صحي.
6. يتم إنشاء روابط منتظمة مع المجتمع الأوسع.

تقييم صحة الأسرة

يتطلب تقييم صحة الأسرة بطريقة منهجية ثلاث أدوات

1. الإطار المفاهيمي
2. فئات جمع البيانات
3. طرق التقييم

1. الأطر المفاهيمية

الإطار المفاهيمي هو مجموعة من المفاهيم المدمجة في إطار ذي معنى تفسير يساعد المرء على تفسير السلوك أو المواقف البشرية. يتم هنا عرض ثلاثة أطر مفيدة بشكل خاص في تمريض صحة المجتمع

1. الأطر التفاعلية:

يصف الأسرة كوحدة من الشخصيات المتفاعلة ويؤكد التواصل والأدوار والصراع وأنماط التأقلم وعمليات صنع القرار

2. الأطر الهيكلية والوظيفية:

يصف الأسرة بأنها نظام اجتماعي يتعلق بالأنظمة الاجتماعية الأخرى في البيئة الخارجية، مثل المدرسة والعمل ونظام الرعاية الصحية.

3. الأطر التنموية:

دراسة الأسر من منظور دورة الحياة من خلال فحص الأعضاء' تغيير الأدوار والمهام في كل مرحلة من مراحل دورة الحياة التقدمية

2. فئات جمع البيانات

1. أنواع وأنواع البيانات المطلوبة

1. بنية الأسرة وخصائصها وديناميكياتها
2. الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والثقافية
3. المنزل والبيئة
4. الحالة الصحية لكل عضو
5. القيم والممارسات المتعلقة بتعزيز الصحة والحفاظ عليها والوقاية من الأمراض.

3. طريقة جمع البيانات

- المصدر الأساسي لجمع البيانات - يتم الحصول عليه مباشرة من العميل (أفراد الأسرة)
- المصدر الثانوي لجمع البيانات - تم الحصول عليه من خلال الأصدقاء والجيران والزلاء وسجلات العائلة وأعضاء فريق العائلة وتقارير التحقيق، الكتب المرجعية الخ.

4. طرق التقييم

➤ يتم استخدام العديد من الأساليب المختلفة لتقييم الأسر. ➤ تهدف هذه الأساليب إلى توليد معلومات حول جوانب مختارة من بنية الأسرة ووظيفتها؛ ويجب أن تتوافق الأساليب مع غرض التقييم.

1. خريطة بيئية

هو رسم تخطيطي للعلاقة بين الأسرة والنظام الآخر في نظامها البيئة الإيكولوجية أو صورة لأنماط الأسرة.

2. جينوجرام

صورة بيانية لتاريخ العائلة، تُستخدم عادةً على مدى ثلاثة أجيال أو أكثر. يرسم الجينوجرام معلومات مثل؛ أ. العلاقات بين أفراد الأسرة

3. خريطة أو شبكة دعم الشبكات الاجتماعية

يعطي تفاصيل حول نوعية وكمية الروابط الاجتماعية.

4. شجرة صحة الأسرة سجل للأمراض التي تحدث في الأسرة.

عملية تمرير صحة الأسرة:

إنها عملية منهجية وحل المشكلات ومنطقية ومتعمدة لمساعدة تنمية الأسرة وتعزيز قدراتها على تلبية احتياجاتها الصحية وحلها مشاكلهم الصحية. ويتكون من خمس مراحل:

1. تقييم

يتضمن الملاحظة وتاريخ التمرير واستشارة مراجعة الأدبيات، المقابلة والتاريخ السريري والتاريخ الجسدي والنفسي الاجتماعي.

2. التشخيص:

وهو يتألف من التشخيص العائلي.

3. التخطيط:

يتضمن تحديد الأولويات، وتحديد الأهداف والغايات، وتشكيل الأسرة خطة الرعاية التمريضية الصحية.

4. التنفيذ:

وهو يتألف من تعبئة الموارد التي تسهل بيئة العمل، التنفيذ والتوثيق.

5. التقييم:

وهو ينطوي على التقييم التلخيصي والتكويني لصحة الأسرة خطة الرعاية التمريضية.

أزمة عائلية

تعريف الأزمة:

اضطراب أو انهيار في النمط الطبيعي أو المعتاد للشخص أو الأسرة أداء. لا يمكن حل الأزمة عن طريق حل المشكلات المعتادة للشخص الموارد/المهارات.

ثلاثة عناصر أساسية لأزمة هم:

موقف مرهق، وصعوبة في التكيف، وتوقيت التدخل. كل تعتبر حالة الأزمة فريدة من نوعها وستتطلب نهجًا مرتبًا تجاه العميل والموقف.

المواقف التي يمكن أن تؤدي إلى أزمة

- الأوضاع العائلية - التحقيق في إساءة معاملة الأطفال، وإساءة معاملة الزوج، وهو أمر غير مخطط له الحمل، وهجر أحد الوالدين، ومرض أحد أفراد الأسرة المزمّن، وعدم وجود الدعم الاجتماعي هو أمثلة على المواقف العائلية التي يمكن أن تخلق التوتر والأزمات.
- الأوضاع الاقتصادية - الضغوط المالية المفاجئة أو المزمّنة هي المسؤولة عن ذلك العديد من الأزمات العائلية، مثل فقدان الوظيفة، والإخلاء، وعدم وجود طعام، وسرقة الأموال أو الممتلكات المنزلية، والنفقات الطبية المرتفعة، وعدم الحصول على نفقة الطفل المدفوعات، استعادة ملكية السيارة، انقطاع المرافق عن الخدمة، الأموال "المفقودة" القمار أو إدمان المخدرات والفقر.
- أوضاع المجتمع - العنف في الأحياء، وعدم كفاية السكن، ونقص من موارد المجتمع، والبرامج التعليمية غير الكافية توضح بعض طرق يمكن للمجتمع من خلالها المساهمة في الأزمات العائلية.
- أحداث حياتية هامة - الأحداث التي يراها معظم الناس سعيدة، مثل الزواج، إن ولادة طفل، أو الترقية في الوظيفة، أو التقاعد، يمكن أن تؤدي إلى أزمة في عائلة؛ طفل يلتحق بالمدرسة، سلوكيات المراهق، البالغ يمكن أن يغادر الطفل المنزل، أو بداية انقطاع الطمث، أو وفاة أحد أفراد أسرته قد تكون أيضًا أحداثًا مرهقة جدًا في الحياة.
- العناصر الطبيعية - الأزمات تنشأ بسبب الكوارث مثل الفيضانات والأعاصير، الحرائق والزلازل الأرضية، أو حتى فترات طويلة من الحرارة والرطوبة العالية، أو الطقس كئيب أو شديد البرودة.

التدخل في الأزمات:

✘ يستجيب العاملون في الحالات والمتخصصون في برامج الإعاقة بالقيام بما يلي:

- قم بإجراء جرد سريع للوضع
- تحديد نوع الأزمة
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الوضع.
- محاولة تهدئة الموقف و/أو طمأنة العميل؛

✘ بمجرد أن يصبح الوضع هادئًا:

- حدد الموارد المجتمعية المتاحة في منطقتك والتي يمكنها المساعدة واتصل بها العميل خلال الأزمة
- توثيق الأحداث قدر الإمكان، مع الحفاظ على السرية عند حدوثها مطلوب.

✘ الحفاظ على المهارات والموارد المهنية:

- تحديد ونشر المعلومات حول موارد المجتمع المتاحة. احتفظ بذلك المعلومات متاحة لجميع العملاء والموظفين.
- ابحث عن فرص تدريب إضافية عندما تكون متاحة.

نظام الإحالة

تعريف نظام الإحالة

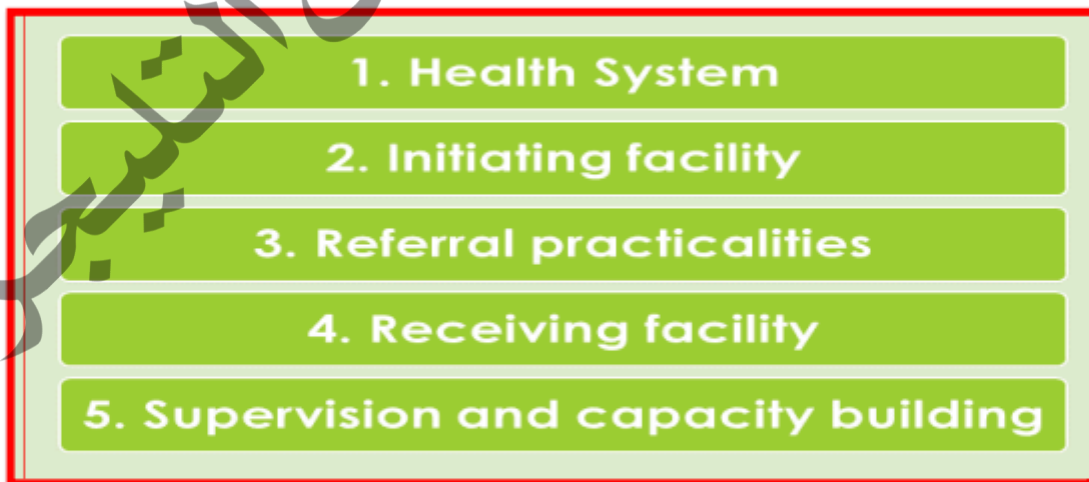
"يتم تعريف نظام الإحالة على أنه نظام نقل القضايا التي تتجاوز الكفاءة الفنية لبنية تحتية واحدة للبنية التحتية ذات المستوى الأعلى / مؤسسة تتمتع بالكفاءة الفنية وجميع الموارد الأخرى اللازمة لتوفير ما هو مطلوب "الخدمات الصحية".

وبعبارة أخرى "يمكن تعريف الإحالة بأنها عملية يقوم فيها العامل الصحي على مستوى واحد من النظام الصحي، عدم وجود موارد كافية (الأدوية والمهارات، المعدات) لإدارة الحالة السريرية، وطلب المساعدة من شخص أفضل أو منشأة ذات موارد مختلفة على نفس المستوى أو أعلى للمساعدة في أو تولي المسؤولية إدارة قضية العميل.

الغرض: يمكن لنظام الإحالة الجيد أن يساعد في ضمان:

- يتلقى العملاء الرعاية المثلى على المستوى المناسب وليس دون داع مكلفة.
- يتم استخدام مرافق المستشفى على النحو الأمثل وبفعالية من حيث التكلفة.
- يمكن للعملاء الذين هم في أمس الحاجة إلى خدمات متخصصة الوصول إليها في الوقت المناسب.
- يتم الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية الأولية بشكل جيد ويتم تعزيز سمعتها.

مكونات نظام الإحالة



Types of Referral		
Routine	Emergency	Opportunistic
• Seeking expert opinion for diagnosis and prognosis. • Seeking hospital admission and management for the case. • Seeking further investigations	• To reach the expert on time before occurrence of deterioration with providing all expected information in referral letter.	• For expert opinion • Investigation • Admission • Management

دور ممرضة صحة الأسرة

- التعاون بين الأسرة والمهنيين الصحيين ▪ العمل كمدافع عن العملاء
- تعزيز وتوفير التشخيص الصحي ▪ مساعدة الأسرة في الوصول إلى الموارد
- توجيه العائلات لتحديد نقاط القوة
- تحديد أولويات التغيير والنمو
- صياغة وتقييم خطط تعديل نمط الحياة
- الأنواع الأربعة الرئيسية للتدخل من قبل ممرضات صحة الأسرة في الوقاية الأولية والثانوية والثالثية، والتدخل في الأزمات/الرعاية المباشرة.

صفات ممرضة صحة الأسرة:

- النهج الذي يركز على الأسرة
- النهج الشامل ① العافية ☎
- لا تحكم أثناء الاقتراب والوعي الذاتي ▪ قبول القيم والمعتقدات المختلفة ▪ القدرة على العمل في ظروف معاكسة ▪ المرونة
- حساس للوقت والجهد
- موقف مستقل وإيجابي ▪ ماهر
- القدرة على التعامل مع التوتر وإدارته ▪ القدرة على التعامل مع الموقف ②

خدمات الصحة المدرسية

مقدمة

تعتبر خدمات الصحة المدرسية بعدا هاما للمجتمع. والأسباب هي العدد الكبير من إجمالي السكان، بسبب النمو والتطور السريع، للكشف المبكر عن الأمراض الغذائية والمعدية، بسبب العيش الجماعي.

خدمات الصحة المدرسية:

يتم تعريفها على أنها "جميع الاستراتيجيات والأنشطة والخدمات التي تقدمها أو فيها" الارتباط بالمدارس المصممة لتعزيز النمو البدني والعاطفي والاجتماعي للطلاب.

التمريض المدرسي:

هي ممارسة متخصصة للتمريض المهني تعمل على تعزيز الرفاهية والنجاح الأكاديمي وتسهيل استجابات الطلاب الإيجابية للتنمية البشرية الطبيعية وتعزيز الصحة والسلامة في البيئة المدرسية.

غرض التمريض المدرسي

- تسهيل استجابات الطلاب الإيجابية للتطور الطبيعي
- تعزيز الصحة والسلامة
- التدخل في المشاكل الصحية الفعلية والمحتملة
- تقديم خدمات إدارة الحالات
- التعاون مع الآخرين لبناء قدرات الطالب والأسرة على التكيف والذات الإدارة والدفاع عن الذات والتعلم.

جوانب خدمات الصحة المدرسية:

أنا. التقييم الصحي لأطفال المدارس والعاملين في المدرسة. ثانيا. التدابير العلاجية والمتابعة. ثالثا. الوقاية من الأمراض المعدية. رابعا. بيئة مدرسية صحية. الخدمات الغذائية. السادس. الإسعافات الأولية والرعاية الطارئة.

سابعاً. الصحة العقلية.viii. صحة الأسنان.ix. صحة العين.x. التثقيف الصحي. الحادي عشر. تعليم الأطفال ذوي الإعاقة. xii. الصيانة والاستخدام السليم لسجلات الصحة المدرسية.

دور ممرضة صحة المجتمع في الصحة المدرسية:

➤ يشمل دور ممرضة المدرسة الاحتياجات الصحية والتعليمية



▪ العمل كمستشار ومعلم في مجال الصحة. ▪ التخطيط للمحاضرات الصحية التي سيتم تقديمها في المدرسة. ▪ تقديم التوجيه للمعلمين وأولياء الأمور فيما يتعلق بالصحة. ▪ العمل كمنسق ومنظم لبرامج الصحة المدرسية. ▪ يوفر الرعاية الصحية المباشرة للطلاب والموظفين ▪ يوفر القيادة لتوفير الخدمات الصحية ▪ يوفر الفحص والإحالة للحالات الصحية ▪ يعزز بيئة مدرسية صحية ▪ يعزز الصحة ▪ الدور القيادي للسياسات والبرامج الصحية ▪ الاتصال بين موظفي المدرسة والأسرة والمجتمع ومقدمي الرعاية الصحية. ▪ المساعدة وسد الفجوة بين ما يتعلمه الطفل في المدرسة والممارسات في البيت.

مقدمة:

تم إنشاء خدمة صحة المسنين (EHS) لتعزيز الرعاية الصحية الأولية لكبار السن الذين يعيشون في المجتمع، يحسنون قدرتهم على الرعاية الذاتية، ويشجعونهم الحياة الصحية وتعزيز الدعم الأسري لتقليل المرض والإعاقة.

تشمل الخدمات:

• خدمة العيادة

تهدف مراكز صحة المسنين إلى تلبية الاحتياجات الصحية المتعددة لكبار السن من خلال توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية المتكاملة لهم. وقائية وتعزيزية و يتم تقديم الخدمات العلاجية من منظور الطب العائلي باستخدام نهج متعدد نهج الفريق التأديبي. كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر مؤهلون للتسجيل أعضاء مراكز صحة المسنين. يتم تزويد الأعضاء المسجلين بخدمات التقييم الصحي والاستشارة والتنقيف الصحي والعلاج العلاجي.

• خدمة التوعية

تواصل الفرق الصحية الزائرة مع المجتمع وأماكن الرعاية السكنية توفير أنشطة تعزيز الصحة لكبار السن وحياتهم المهنية بالتعاون مع مقدمي خدمات المسنين الآخرين. الهدف هو زيادة وعيهم الصحي، قدرة كبار السن على الرعاية الذاتية، وتحسين جودة تقديم الرعاية.

• الصحة العامة والإدارة

يدعم قسم الصحة العامة والإدارة تشغيل المسنين المراكز الصحية والفرق الصحية الزائرة ويقدم مدخلات مهنية بشأنها القضايا المتعلقة بصحة المسنين على المستوى المشترك بين الإدارات. البيانات التي تم جمعها يوميًا تُستخدم عمليات الخدمة لمراقبة الحالة الصحية لكبار السن وإجراء الأبحاث أغراض.

الطلاب' التقييم الذاتي

أ. ما هي الأنشطة التي ستشملها ممرضة المدرسة عند الاستعداد لموسم الأنفلونزا؟
حدد كل ما ينطبق.

أ. تعليم إعادة استخدام الأنسجة ب. توفير معقمات الأيدي ج. تعليمات حول غسل
اليدين د. البقاء في المنزل عند الإصابة بالحمى. إعطاء لقاحات الانفلونزا

كانت ممرضة الصحة المنزلية في جامعة البحرين تقوم بزيارة أولية لرجل مسن. كما
هو الحال بدأت الممرضة التقييم، وقدمت الزوجة جميع المعلومات المطلوبة. أي من
الإجراءات التالية ستخذها الممرضة بعد ذلك؟

أ. الاتفاق على التدخلات المناسبة مع الأسرة ب. إنشاء التشخيصات التمريضية
المناسبة ج. تقييم بيئة المجتمع الأوسع د. تأكيد المعلومات التي تم الحصول عليها
مع العميل

ج. مناقشة دور ممرضة المجتمع في خدمات صحة الأسرة.

د. شرح عملية نظام الإحالة.

الفصل الرابع

(الصحة البيئية والمهنية)

- بيئة
- مهني
- الصحة الريفية

الصحة البيئية

أهداف التعلم

في نهاية الفصل سيكون الطالب قادرًا على:-

1. تعريف المصطلحات البيئية، علم البيئة، و المحيط الحيوي.
2. أهمية الصحة البيئية للتمريض
3. تحديد المبادئ البيئية لتمرير الصحة العامة
4. تحديد مجالات الصحة البيئية ومشاكل الصحة البيئية
5. تعداد آثار المخاطر البيئية
6. مناقشة آثار البيئة الصحية.
7. مناقشة دور التمريض في الصحة البيئية

مقدمة

تشير النظرية النقدية إلى أن الممرضات يجب أن يكونوا على دراية بالتهديدات أو العوامل البيئية التي قد تؤثر سلبيًا على سلامة ورفاهية مجموعات سكانية معينة أو تحرمهم من الوصول إلى الموارد اللازمة في السعي لتحقيق الصحة. وقد يشمل هذا الوعي التعرف على التأثيرات البيئية الإيجابية ودعمها والحفاظ عليها. على سبيل المثال، يجب على الممرضة أن تأخذ في الاعتبار آثار وجود الوصول إلى مكان آمن للمشاة على قدرة الفرد على الحفاظ على صحته.

ال بيئة يتم تعريفها على أنها جميع الظروف والظروف والمؤثرات الخارجية المحيطة والمؤثرة على نمو وتطور كائن حي أو مجتمع من الكائنات الحية.

بيئة دراسة كيفية تفاعل الكائنات الحية مع بعضها البعض ومع بعضها البعض بيئة

المحيط الحيوي المنطقة من الأرض التي توجد بها الحياة تُعرف باسم.

منظمة الصحة العالمية (منظمة الصحة العالمية) تعرف الصحة البيئية بأنها "الكل العوامل الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية الخارجية للشخص وجميع العوامل ذات الصلة التي تؤثر على السلوكيات.

أهمية الصحة البيئية للمريض

- 1- دور الممرضات في تعزيز الشفاء والبيئات الآمنة للناس.
- 2- تعمل الممرضات مع مجموعات سكانية متنوعة في المنازل وأماكن العمل والمجتمعات.
- 3- الممرضون هم أحد المهنيين الأكثر ثقة، وهم قادرون على توصيل المعلومات المعقدة إلى مرضاهم ومجتمعاتهم، والتفاعل مع العديد من منظمات الرعاية الصحية الأخرى.

مبادئ الصحة البيئية لممارسة التمريض

1. إن معرفة مفاهيم الصحة البيئية أمر ضروري لممارسة التمريض.
2. يرشد مبدأ الحيطة الممرضات في ممارساتهن إلى استخدام المنتجات والممارسات التي لا تضر بصحة الإنسان أو البيئة واتخاذ إجراءات وقائية في حالة عدم اليقين.
3. للممرضات الحق في العمل في بيئة آمنة وصحية.
4. يتم الحفاظ على البيئات الصحية من خلال التعاون متعدد التخصصات.
5. يعتمد اختيار المواد والمنتجات والتكنولوجيا والممارسات في البيئة التي تؤثر على ممارسة التمريض على أفضل الأدلة المتاحة.
6. تعكس الأساليب المتبعة لتعزيز بيئة صحية احترام القيم والمعتقدات والثقافات والظروف المتنوعة للمرضى وأسرتهم.
7. يشارك الممرضون في تقييم جودة البيئة التي يعيشون فيها الممارسة والعيش.
8. يحق للممرضات وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى والمجتمعات معرفة المعلومات ذات الصلة وفي الوقت المناسب حول المنتجات والمواد الكيميائية والملوثات والمخاطر التي يحتمل أن تكون ضارة والتي يتعرضون لها.
9. تشارك الممرضات في البحث عن أفضل الممارسات التي تعزز بيئة آمنة وصحية.
10. يجب دعم الممرضات في الدعوة إلى البيئة وتنفيذها المبادئ الصحية في ممارسة التمريض.

مجالات الصحة البيئية

مساحة	تعريف	مشاكل
البيئة المبنية	المباني، المساحات، و المنتجات التي تم إنشاؤها أو قابل للتعديل بواسطة الناس، بما في ذلك المنازل والمدارس وأماكن العمل والحدائق/ مناطق الترفيه والممرات الخضراء ومناطق الأعمال وأنظمة النقل.	- القيادة تحت تأثير الكحول - التدخين السلبي - التعرض للضوضاء - الازدحام الحضري - المخاطر التكنولوجية
متعلق بالعمل التعرض	التعرض المهني للمخاطر البيئية التي يمكن أن يسبب المرض أو الإصابة.	- التعرض للأسبستوس - الحوادث الزراعية - التعرض المفرط للأشعة السينية
جودة الهواء الخارجي	حماية طبقات الغلاف الجوي، ومخاطر الطقس القاسي، ونقاء الهواء لأغراض التنفس.	- الملوثات الغازية - تأثير الاحتباس الحراري - تدمير طبقة الأوزون - هوائي رش من مبيدات الأعشاب والمبيدات الحشرية - المطر الحمضي - انبعاثات المنشآت النووية
منزل صحي	ال توفر، السلامة، الهيكليّة القوة، النظافة وموقع المأوى، بما في ذلك المرافق العامة والعائلية المساكن. ويتضمن ذلك جودة الهواء الداخلي.	- التشرد - القوارض والحشرات الإصابة - وجود طلاء يحتوي على الرصاص - متلازمة المبنى المريض - الأحياء غير الآمنة - تسرب غاز الرادون في المنازل والمدارس

جودة المياه	توافر إمدادات المياه النظيفة وإمكانية الوصول إليها، ومستويات المحتوى المعدني، والتلوث بالمواد الكيميائية السامة، ووجود مسببات الأمراض الكائنات الحية الدقيقة.	- تلوث إمدادات الشرب بالنفايات البشرية - الانسكابات النفطية في الممرات المائية في العالم - مبيد حشري أو مبيد أعشاب تسرب المياه الجوفية - تلوث طبقة المياه الجوفية بالملوثات الصناعية - التسمم بالمعادن الثقيلة في الأسماك
سلامة الغذاء	التوفر النسبي التكاليف والتنوع والسلامة و صحة مصادر الغذاء الحيواني والنباتي.	- سوء التغذية - التسمم الغذائي البكتيري - غش الطعام - تعطيل السلاسل الغذائية عن طريق تدمير النظام البيئي - المواد الكيميائية المسببة للسرطان المضافة للأغذية
إدارة النفايات	إدارة النفايات المواد الناتجة عن العمليات الصناعية والبلدية والبشرية الاستهلاك، والجهود المبذولة لتقليل إنتاج النفايات.	- استخدام البلاستيك غير القابل للتحلل البيولوجي - مقالب النفايات الصلبة سيئة التصميم - عدم كفاية شبكات الصرف الصحي - نقل وتخزين النفايات الخطرة - الإغراق الصناعي غير القانوني - مشع خطير النفايات

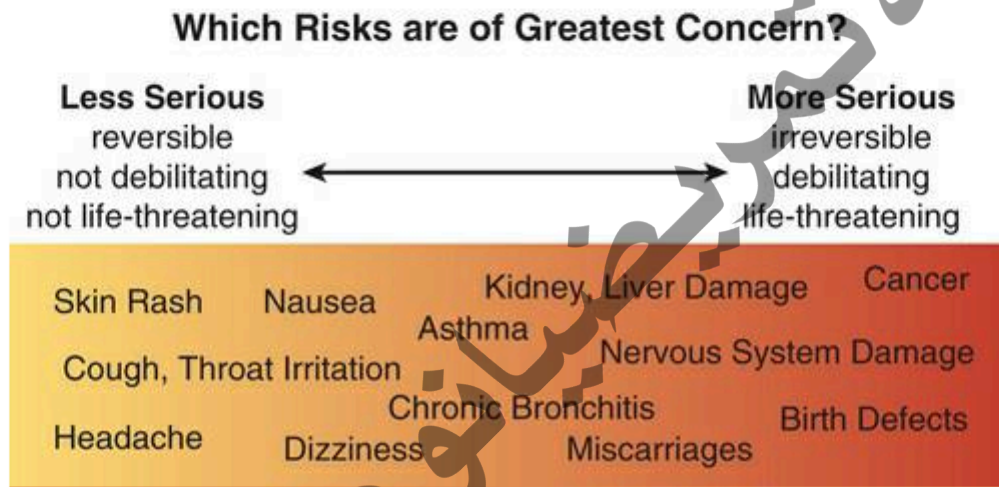
آثار المخاطر البيئية

قد تكون تأثيرات المخاطر البيئية عامة أو محددة.

• **التأثيرات العامة:-** تؤثر تداعيات ارتفاع معدلات البطالة والجفاف والغطاء الدخاني الواسع النطاق على الجمهور بشكل عام.

• **تأثيرات محددة:-** إن الاحتياجات السكنية لكبار السن الذين يستخدمون المشايات أو العصي، والمخاطر المهنية لعمال إصلاح الخطوط الكهربائية، والآثار المسببة للعجز العقلي لارتفاع قيم الرصاص في الدم لدى الأطفال، تؤثر على الجمهور بشكل أكثر تحديدًا.

درجات التأثيرات الصحية الناجمة عن التعرض البيئي



الآثار الصحية البيئية

يمكن أن تكون التأثيرات على الصحة البيئية فورية، أو طويلة الأمد، أو تنتقل بين الأجيال.

التأثير الفوري على الصحة البيئية

الحروق، وجروح الطلقات النارية، وأضرار الأعاصير، وتفشي اضطرابات الجهاز الهضمي بين زبائن الكافيتريا.

التأثير على الصحة البيئية على المدى الطويل

فقدان السمع المهني التدريجي، "الرئة السوداء" لدى عمال مناجم الفحم، وزيادة معدلات الإصابة بسرطان الغدة الدرقية بين الشباب ضحايا حادث مفاعل تشيرنوبيل النووي.

التأثيرات الصحية البيئية بين الأجيال

ومن المرجح أن يحدث ذلك مع تغير المناخ من خلال التأثير على النساء في سن الإنجاب.

ومن الأمثلة على الجهود المبذولة لرصد وتحسين الصحة البيئية مؤتمر الأمم المتحدة السنوي لتغير المناخ.

كل عام، تجتمع البلدان التي انضمت إلى المحادثة الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (UNFCCC) من أجل: -

- قياس التقدم والتفاوض بشأن الاستجابة المتعددة الأطراف لتغير المناخ.
- تثبيت تركيز الغاز المستخدم في الغلاف الجوي عند مستوى يمنع ذلك التدخل البشري الخطير في النظام المناخي

دور التمريض في الصحة البيئية

1. يجب على الممرضات العمل مع الجمهور لتعزيز إجراءات أكثر صرامة و
2. التشريعات واللوائح البيئية المطبقة بشكل فعال.
3. يجب أن تشمل الإجراءات ليس فقط البيئة الوطنية ولكن أيضًا البيئة العالمية سياسات.
4. المخاوف البيئية بشأن الهواء النظيف والمياه النظيفة والحرية
5. من المواد الكيميائية الضارة يجب أن تصبح مخاوف تمريضية.
6. يمكن لممرضات صحة المجتمع أن يكونوا محفزين لجهود الأحياء لإنتاج بيئات معيشية آمنة.
7. يجب على تمريض صحة المجتمع أن يوسع نظريته وممارسته لتشمل حقيقة أن صحة الفرد والمجتمع تعتمد في نهاية المطاف على سلامة البيئة العالمية.
8. يجب أن يتضمن التمريض منظورًا بيئيًا من خلال الالتزام بمبادرات تعزيز الصحة البيئية التي تعزز العدالة الاجتماعية والمسؤولية البيئية.

في نهاية الفصل سيكون الطالب قادرًا على :- 1- تعريف الصحة المهنية.

2- تحديد خدمات التمريض الصحي المهني.

3- تعداد الأولويات في تمريض الصحة المهنية.

4- مناقشة أنواع المخاطر المهنية.

5- إظهار مهارات التمريض في مجال الصحة المهنية.

مقدمة

الصحة المهنية، بما في ذلك علم السموم، للتعرف على طرق التعرض، وفحص العلاقات بين التعرض للمواد الكيميائية في مكان العمل والآثار الصحية الحادة والكامنة مثل الحروق أو السرطان، وفهم الاستجابة للجرعة العلاقات؛ النظافة الصناعية ، لتحديد وتقييم المخاطر في مكان العمل حتى يمكن تنفيذ آليات التحكم للحد من التعرض؛ السلامة، لتحديد الإصابات في مكان العمل والسيطرة عليها من خلال الضمانات النشطة وبرامج تدريب العمال وتثقيفهم حول الوظيفة أمان ؛ و بيئة العمل ، لمطابقة الوظيفة مع العامل، مع التركيز على القدرات وتقليل القيود.

يتم تعريف التخصص الفرعي لتمريض الصحة العامة من قبل الجمعية الأمريكية لمرضات الصحة المهنية (AAOHN) على النحو التالي :

- الممارسة التخصصية التي تركز على تعزيز الصحة والوقاية منها واستعادتها في سياق بيئة آمنة وصحية.
- ويشمل ذلك الوقاية من الآثار الصحية الضارة الناجمة عن المخاطر المهنية والبيئة.
- وهي توفر وتقدم برامج وخدمات الصحة والسلامة المهنية والبيئة للعاملين.



مجالات المعرفة في مجال التمريض الصحي المهني

خدمات تمرير الصحة المهنية

- مكان عمل آمن وصحي
- الاستجابة الطبية الطارئة
- اختيار وتدريب المستجيبين للإسعافات الأولية
- مساحة الإسعافات الأولية والإمدادات والبروتوكولات والسجلات
- الموارد الطبية المخصصة للاستجابة للحوادث
- تعويضات العمال
- سرية السجلات الطبية
- الامتثال لمتطلبات الاحتفاظ بالسجلات الطبية
- الامتثال لإدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA)
- متطلبات الطاقم الطبي
- الإبلاغ عن الإصابات والأمراض وتسجيلها
- التحقيق في الحوادث والإصابات
- الوقاية من اضطراب الصدمات التراكمية
- وصول الموظفين إلى السجلات الطبية وسجلات التعرض
- المراقبة الطبية وتأهيل الأعمال الخطرة
- تقييم معدات الحماية الشخصية والتدريب عليها
- مكافحة العدوى
- الإخطار والتدريب بموجب قانون حق الموظف في المعرفة
- الامتثال لقانون حق المجتمع في المعرفة
- قانون إعادة التأهيل: الإعاقة، والتأهيل المسبق، وتقييمات اللياقة للواجب، والإقامة
- وزارة الدفاع، ووزارة النقل، ولجنة التنظيم النووي، والامتثال لقانون مكان العمل الخالي من المخدرات
- تطوير السياسات
- التحقيق بشأن المخدرات
- اختبار المخدرات والدعم الفني
- خدمات برنامج مساعدة الموظفين
- التهديد بالعنف وواجب التحذير
- لوائح الصحة العامة الحكومية والمحلية
- أعمال ممارسة التمرير
- لوائح مجلس الصيدلة ووكالة مكافحة المخدرات

• التعليم المهني المستمر المطلوب لخدمات الترخيص التي غالبًا ما تفرضها سياسة الشركة

• الإشراف السريري على الخدمات الصحية في الموقع

• تطوير الاستراتيجية الصحية

• معايير الخدمات الصحية

• المساحة والموظفين والمعايير التشغيلية

• تقييم الأمراض والإصابات المهنية وتشخيصها وعلاجها وإحالتها

• تقييم الأمراض والإصابات غير المهنية وتشخيصها وعلاجها وإحالتها

• تقييمات الإعاقة والعودة إلى العمل وأماكن الإقامة

• تقييم ضعف لياقة الموظف للواجب

• التقييم المسبق والإقامة الطبية

• تقييم الإعاقة والتنسيب والإقامة

• معايير برنامج مساعدة الموظفين

• الصحة الدولية: السفر والاستشارات الطبية والتطعيمات

• جمع البيانات وتحليلها

• استشارة طبية

• وضع الحمل في بيئات خطرة

• التعليم والتطوير المهني

• التدقيق وضمان الجودة

الأولويات في تمرير الصحة المهنية

• فعالية تقديم الرعاية الصحية الأولية في مكان العمل

• فعالية استراتيجيات التدخل التمريضي لتعزيز الصحة

• طبيعة وتأثيرات الإجهاد والضغوطات في مكان العمل على صحة العمال

• الاستراتيجيات التي تقلل من النتائج الصحية الضارة المرتبطة بالعمل (على سبيل المثال، أمراض الجهاز التنفسي)

• الآثار الصحية الناتجة عن التعرض للمواد الكيميائية في مكان العمل

• المخاطر المهنية للعاملين في مجال الرعاية الصحية (على سبيل المثال، حساسية اللاتكس ومسببات الأمراض المنقولة بالدم)

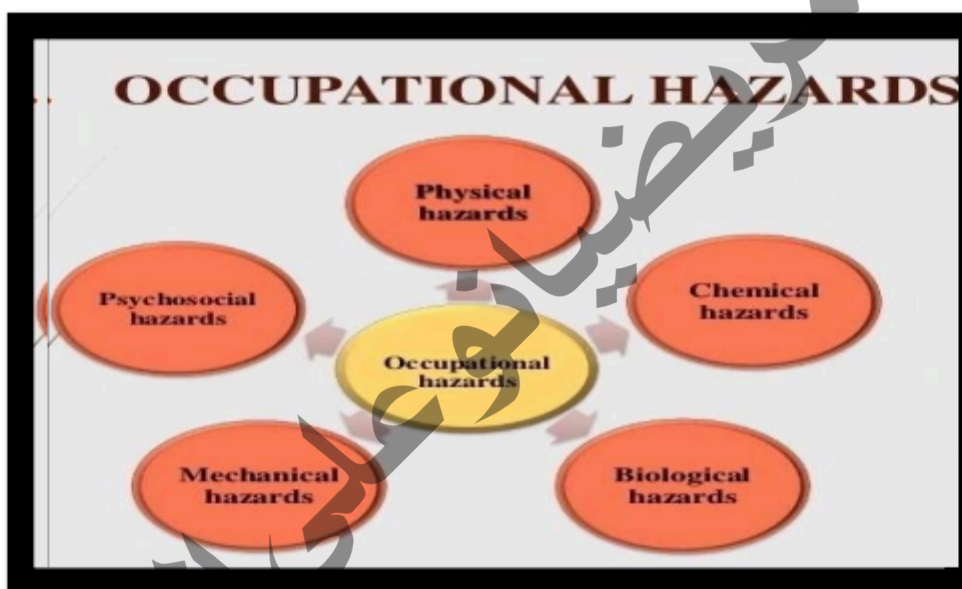
• العوامل المؤثرة على العمال ' إعادة التأهيل والعودة إلى العمل

• فعالية الاستراتيجيات المريحة للحد من إصابات العمال وأمراضهم

• الآثار الصحية الناتجة عن التفاعل بين الشيخوخة ومكان العمل المخاطر

- تقييم المسارات الحاسمة لتحسين أداء العمال بشكل فعال أو الصحة والسلامة وتعزيز أقصى قدر من التعافي والعودة الآمنة إلى العمل
- تقييم استراتيجيات التدخل لتحسين صحة العمال وسلامتهم
- استراتيجيات لزيادة الالتزام بمعدات الحماية الشخصية أو تحفيز العمال على استخدامها
- الاستعداد للطوارئ/الأوبئة في مكان العمل
- تأثير تدخلات التمريض الصحي المهني على مطالبات تعويضات العمال

المخاطر المهنية والآثار الصحية المرتبطة بها



أنواع المخاطر المهنية والآثار الصحية المرتبطة بها

التأثيرات الصحية	التعرضات	التصنيف
البكتيرية والفطرية والفيروسية الالتهابات (على سبيل المثال، التهاب الكبد B)	الدم أو سوائل الجسم	بيولوجي
الصداع وخلل في الجهاز العصبي المركزي	المذيبات	كيميائي
الجهاز العصبي المركزي اضطرابات	يقود	
مرض الأسبستوس	الاسبستوس	
الحروق	الأحماض	
مشاكل الإنجاب	إشعاعات الجليكول	

الزئبق	ترنج	
الزرنخ	اعتلال الأعصاب الطرفية	
الوضعية الثابتة أو غير الطبيعية	اضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي	الميكانيكية البيئية
المجهودات المتكررة أو القسرية	إصابات الظهر	
إضاءة	الصداع وإجهاد العين	
العمل بنظام المناوبات	اضطرابات النوم	
كهربائي	صعق كهربائي	
ينزلق ويسقط	الحالات العضلية الهيكلية	
ضرب بواسطة أو ضد شيء ما	إصابة	
ضوضاء	فقدان السمع	فيزيائي
إشعاع	التأثيرات الإنجابية والسرطان	
اهتزاز	مرض رينود	
حرارة	الإرهاق الحراري وضربة الشمس	
ضغط	ردود الفعل القلبية ومجموعة متنوعة من الأعراض الجسدية	نفسي اجتماعي

مهارات تمريض الصحة المهنية

الرعاية السريرية والأولية

- تطبيق العملية التمريضية في تقديم الرعاية. ▪ تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الأولية وفقًا لبروتوكولات العلاج. ▪ إجراء تقييم جسدي. ▪ أخذ تاريخ الصحة المهنية والبيئية. ▪ التشخيص والعلاج. ▪ أن تكون على دراية ببروتوكولات التحصين. ▪ تحديد الاحتياجات العاطفية للموظفين وتقديم الدعم والمشورة. ▪ استخدام نهج متعدد التخصصات لحل المشكلات المتعلقة بأمراض وإصابات الصحة المهنية. ▪ صيانة السجلات. ▪ الاختبارات السريرية والمراقبة. ▪ الاستجابة لحالات الطوارئ الطبية. ▪ أن يكون على دراية بالاتجاهات في القضايا المتعلقة بالصحة.

إدارة الحالة

- تحديد الحاجة إلى خدمات إدارة الحالات ▪ إجراء تقييمات إدارة الحالات باستخدام إطار متعدد التخصصات ▪ تطوير خطط رعاية إدارة الحالات

▪ تقييم الموارد والبائعين لإدارة الحالات ▪ تنفيذ برامج العودة المبكرة إلى العمل ▪ مراقبة وتقييم النتائج ▪ تطوير السياسات والبرامج لإدارة الحالات ▪ تحليل الاتجاهات لخدمات إدارة الحالات ▪ تصميم أنظمة إدارة الإعاقة ▪ إجراء البحوث القائمة على نتائج إدارة الحالات

من فئة تدريبيات نوع على التليجرام

الصحة الريفية

أهداف التعلم

في نهاية الفصل سيكون الطالب قادرًا على:- 1- تعريف الصحة الريفية.

2- توضيح الفوارق الصحية في المناطق الريفية

3- مناقشة أسباب التفاوتات الصحية في المناطق الريفية.

4- مناقشة دور تمريض صحة المجتمع في الصحة الريفية.

مقدمة:

توفر ممارسة التمريض الريفي العديد من الفرص. الممرضات أعضاء محترمون في المجتمع—حكمهن وأرائهن مهمة. الممرضون الريفيون هم أعضاء رئيسيون في فريق الرعاية الصحية. يمكنهم أن يحدثوا فرقًا في حياتهم الجيران والأصدقاء والمجتمع. غالبًا ما يواجه ممرضو الصحة العامة في المناطق الريفية (PHNs) صعوبة في مساعدة العملاء في الحصول على رعاية صحية عالية الجودة ومشاكل النقل المتأصلة الموجودة في المناطق المعزولة. التحديات كثيرة، لكن المكافآت عظيمة.

تعريفات الصحة الريفية:

الصحة الريفية هي صحة الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية، والذين يقعون عمومًا بعيدًا عن مرافق الرعاية الصحية والخدمات الأخرى مقارنة بالأشخاص الذين يعيشون في المناطق الحضرية.

الفوارق الصحية الريفية

▪ سكان الريف معرضون بشكل أكبر لخطر الوفاة بسبب:-

- أمراض القلب

- سرطان

- سكتة دماغية

- إصابة غير مقصودة (على سبيل المثال: وفاة سيارة))

- مرض الجهاز التنفسي السفلي المزمن

▪ كما أن سكان الريف أكثر عرضة للإصابة بحالات صحية متعددة مقارنة بالأشخاص الذين يعيشون في مناطق أخرى.

▪ تعد أمراض القلب والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم والسكري والتهاب المفاصل أمثلة على الحالات الصحية الأكثر شيوعًا في المناطق الريفية.

▪ داخل المناطق الريفية، أفراد الأقليات العرقية/الإثنية والقبلية وغيرها من الأقليات المتنوعة المجموعات أكثر عرضة لخطر النتائج الصحية السيئة

الأسباب التفاوتات الصحية في المناطق الريفية

تشمل العوامل التي تجعل الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية أكثر عرضة لنتائج صحية سيئة ما يلي:

1. انخفاض فرص الحصول على الرعاية الصحية بسبب قلة عدد مقدمي الرعاية الصحية والمرافق الطبية وخيارات النقل.
2. التعرض لمخاطر بيئية محددة، مثل التلوث وسوء نوعية الهواء والمياه
3. ارتفاع معدلات تدخين السجائر وارتفاع ضغط الدم والسمنة
4. نشاط بدني أقل في أوقات الفراغ
5. استخدام حزام الأمان السفلي
6. الصحاري الغذائية والمناطق التي بها خيارات أقل للبقالة وانخفاض توافر الأطعمة الصحية
7. ارتفاع معدلات الفقر وانخفاض احتمالات الحصول على التأمين الصحي

دور التمريض في صحة المجتمع الريفي.

1. محامي: يساعد العملاء والأسر الريفية في الحصول على أفضل رعاية ممكنة
2. منسق/قضية مدير: يربط العملاء الريفيين بالخدمات الصحية والاجتماعية اللازمة، وغالبًا ما يساعد في توفير المعلومات حول النقل
3. معلم صحة: يوفر التعليم للأفراد أو الأسر أو المجموعات حول تعزيز الصحة أو غيرها من المواضيع المتعلقة بالصحة (على سبيل المثال، الولادة الجاهزة، وتربية الأطفال، والحفاظ على مرض السكري، والسلامة المنزلية)
4. وكيل الإحالة: يقوم بإنشاء اتصالات مناسبة بين العملاء الريفيين ومقدمي الخدمات الحضرية
5. معلم: يرشد ممرضات صحة المجتمع الجدد وطلاب التمريض وغيرهم الممرضات الجدد في المجتمع الريفي
6. وكيل التغيير/الباحث: يقترح أساليب جديدة لحل مشاكل رعاية المرضى أو صحة المجتمع بناءً على الأبحاث والأدبيات المهنية وتقييم المجتمع
7. متعاون: يسعى إلى إيجاد طرق للعمل مع المتخصصين الآخرين في مجال الصحة والخدمات الاجتماعية لتحقيق أقصى قدر من النتائج للعملاء والأفراد والمجتمع ككل
8. ناشط: مع الفهم العميق للمجتمع وسكانه، يتحمل المخاطر المناسبة لتحسين صحة المجتمع.

الفصل الخامس

المعدية وغير المعدية أمراض

1- الأمراض المعدية

أهداف التعلم

في نهاية الفصل سيكون الطالب قادرًا على:- 1- تعريف الأمراض المعدية

2- تحديد المصطلحات الأساسية

3- توضيح سلسلة العدوى

4- تحديد عوامل خطر الإصابة بالأمراض المعدية

5- اذكر أمثلة على الأمراض المعدية الشائعة

6- تحديد الوقاية من الأمراض المعدية

7- اذكر دور التمريض في رعاية المرضى المصابين بالأمراض المعدية

مقدمة

تحدث الأمراض المعدية في كل بلد، وفي كل منطقة حضرية وريفية، وفي كل حي، من الأغنياء جدًا إلى الفقراء جدًا. يجب أن يكون لدى الممرضات اللاتي يقدمن رعاية جيدة في مكافحة الأمراض المعدية فهم أساسي لعلم الأوبئة ومكافحة العدوى وعلم الأحياء الدقيقة والطب والصحة العامة والتمريض. علاوة على ذلك، يجب أن يكون لدى ممرضة المجتمع معرفة بالنظام القانوني، والذي ينص على الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها محليًا ووطنياً وعالمياً. ويجب على الممرضات أيضًا أن يكون لديهن معرفة بأنظمة الدعم الفعالة التي يمكن للأفراد والأسر والمجتمعات استخدامها.

تعريف الأمراض المعدية

هو الذي يمكن أن ينتقل من شخص إلى آخر وينتج عن عامل معدي ينتقل من مصدر أو خزان إلى مضيف حساس.

المصطلحات الأساسية

- **عدوى:** هو دخول وتطور أو تكاثر العامل المعدي في جسد الإنسان أو الحيوان. العدوى لا تسبب المرض دائماً
- **متوطن:** يشير إلى الوجود المستمر للمرض داخل منطقة جغرافية ما أو السكان. (على سبيل المثال) السعال الديكي متوطن فينا.
- **وبائي:** يشير إلى حدوث المرض في مجتمع أو منطقة في زيادة عن المعدل الطبيعي المتوقع.
- **الوباء:** يشير إلى وباء يحدث في جميع أنحاء العالم ويؤثر على نطاق واسع السكان. على سبيل المثال انفلونزا الخنازير
- **فترة الحضانة:** الفترة الزمنية بين التعرض لعامل معدي وظهور أول علامة أو عرض للمرض المعني.
- **إزالة:** هدفها إزالة المرض من منطقة جغرافية كبيرة مثل كدولة أو منطقة في العالم (من خلال البرامج والحملات) (على سبيل المثال) القضاء على (شلل الأطفال) من أمريكا 1994.
- **القضاء:** هدفها هو التخلص من المرض بشكل كامل عن طريق القضاء عليه
- العوامل المعدية في جميع أنحاء العالم (من خلال البرامج والحملات) (على سبيل المثال) القضاء على الجدري في مايو 1980

سلسلة العدوى

- **عامل معدي:** أي مرض يسبب الكائنات الحية الدقيقة (مسببات الأمراض)، المعدية العوامل هي: بكتيرية، فيروسية، فطرية، طفيلية
- **الخزان:** عندما تعيش الكائنات الحية الدقيقة وتكاثر بشكل طبيعي، فقد يحدث ذلك كن بشراً (حالة أو حاملاً)، حيوانات، ماء، طعام
- **بوابة الخروج:** طريق هروب العامل الممرض من الخزان، كجهاز تنفسي إفرازات، دم، تشققات في الجلد، على سبيل المثال: الأنفلونزا أو البرد من خلال الإفرازات المخاطية، التهاب الكبد A من خلال البراز، T. B من خلال القطرات
- **طريقة الإرسال**

1-مباشر

- أ- الاتصال المباشر (اللمس/السعال)
- ب- الهواء المولود (قطرات الغبار-نوى القطرات) ج- عبر المشيمة

2- في الاتجاه المباشر

أ- مولود مركبة (طعام/دم/ألعاب/دخان) ب- مولود ناقل (ميكانيكي) ج- مولود هوائي

• بوابة الدخول : الطريق الذي يدخل من خلاله العامل الممرض إلى مضيفه الجديد

، من خلال الاستنشاق والابتلاع والاتصال الجنسي، يكسر حواجز الجلد الواقية.

• المضيف المعرض للخطر : قد يكون الكائن الحي الذي يقبل العامل الممرض رجل أو حيوان.

عوامل الخطر المعدية

1. عمر: الأطفال دون سن الخامسة، الأوامر محفوفة بالمخاطر
2. مهنة: بعض المهن أكثر عرضة للإصابة بالعدوى مثل المزارعين على اتصال مع الحيوانات والعاملين الطبيين وشبه الطبيين.
3. الجنس : بعض حالات العدوى تكون أكثر عند الذكور وبعضها أكثر عند الإناث
4. العوامل الاجتماعية: الطبقة الاجتماعية والاقتصادية المنخفضة، الفقر، العادات الصحية السيئة
5. العوامل البيئية: منازل صحية سيئة، اكتظاظ.
6. سوء التغذية: يؤدي إلى مقاومة منخفضة
7. مرض مزمن وموهن: حالة تقلل من المقاومة مثل داء السكري وفيروس نقص المناعة البشرية
8. حصانة: انخفاض المناعة يمكن أن يكون عامل خطر
9. العامل النفسي

أمثلة على الأمراض المعدية الشائعة

1- فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)

□ فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) هو فيروس يهاجم الخلايا التي تساعد الجسم على مكافحة العدوى، مما يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والأمراض الأخرى.

طريقة الإرسال

• يجب تعريض السوائل المصابة للأنسجة التالفة أو مناطق الجسم التي تحتوي على الأغشية المخاطية، مثل بطانة المستقيم أو المهبل، لتنتشر الفيروس .

• يمكن للأمهات نقل الفيروس إلى الرضع أثناء الحمل أو الولادة

- وقد يؤدي الحقن من إبرة أو حقنة ملوثة أيضًا إلى نقل الفيروس مباشرة إلى مجرى الدم.

العلامات والأعراض

- حمى.
- صداع.
- آلام العضلات وآلام المفاصل.
- متسرع.
- التهاب الحلق وتقرحات الفم المؤلمة.
- تورم الغدد الليمفاوية، خاصة في الرقبة.
- إسهال.
- فقدان الوزن.

وقاية

- يقلل من حدوث انتقال العدوى (على سبيل المثال، يصاب عدد أقل من الأشخاص بفيروس نقص المناعة البشرية)
- تجنب الاتصال الجنسي مع الأفراد المصابين
- تجنب مشاركة الإبر/المحاقن التي قد تكون ملوثة بفيروس نقص المناعة البشرية
- تجنب أي نوع من الاتصال بالسوائل الجسدية للشخص المصاب.

2- التهاب الكبد الوبائي سي

- التهاب الكبد C هو عدوى في الكبد يمكن أن تؤدي إلى تلف خطير في الكبد.
- إنه ناجم عن فيروس التهاب الكبد C. لكنه يسبب أعراضًا قليلة، لذلك لا يعرف معظم المرضى ذلك.

طريقة الإرسال

- وينتشر الفيروس عن طريق دم الشخص المصاب أو سوائل جسمه.
- مشاركة أدوية الحقن والإبر
- ممارسة الجنس، خاصة إذا كنت مصابًا بمرض منقول جنسيًا، أو عدوى بفيروس نقص المناعة البشرية، أو لديك عدة شركاء، أو تمارس الجنس العنيف
- أن تكون عاليًا بالإبر المصابة
- الولادة -- يمكن للأم أن تنقلها إلى الطفل
- مشاركة أدوات العناية الشخصية مثل فرشاة الأسنان وشفرات الحلاقة ومقصات الأظافر.

العلامات والأعراض

- براز بلون الطين
- البول الداكن
- حمى
- تعب
- اليرقان (حالة تسبب اصفرار العينين والجلد، وكذلك البول الداكن)
- آلام المفاصل
- فقدان الشهية
- غثيان
- آلام المعدة

وقاية

أ- **التثقيف الصحي:** لتثقيف الجمهور حول طريقة انتقال العدوى وطرق الحماية

- تجنب مشاركة الأغراض الشخصية مثل شفرات الحلاقة أو فرشاة الأسنان،
- أدوات الأصابع.
- لا تشارك إبر المخدرات
- تنظيف بقع الدم

ب- **تعزيز الصحة:**

تغذية جيدة، نمط حياة صحي.

- تناول الحبوب الكاملة والخبز والحبوب

- تناول الكثير من الفواكه والخضروات

- احصل على كمية كافية من البروتين

- اشرب الكثير من السوائل

3- السل الرئوي

- **معدي مرض** قد يصيب أي جزء من الجسم، ويعتبر مرض السل الرئوي هو الأكثر شيوعاً.

طرق الإرسال:

• **قطرة مباشرة:** يجد الكائن الحي مخرجاً من خلال إفرازات الجهاز التنفسي عند السعال.

• **غير مباشر:** محمولة جواً، لعبة

العلامات والأعراض

- قلة الشهية وفقدان الوزن
- درجة حرارة عالية
- التعرق الليلي
- التعب الشديد أو التعب
- سعال مستمر يستمر لأكثر من 3 أسابيع وعادة ما يؤدي إلى ظهور البلغم الذي قد يكون دمويًا
- ضيق التنفس الذي يزداد سوءًا تدريجياً

وقاية:

الوقاية العامة:

- البيئة الصحية
- التشييف الصحي: لتشيف الجمهور حول طرق انتقال العدوى وطرق الوقاية
- تعزيز الصحة: تغذية جيدة، نمط حياة صحي.

الوقاية المحددة:

- التطعيم: بواسطة BCG يُعطى للرضع، الجرعة: 1 مل داخل الأدمة

4- التيفوئيد

حمى التيفوئيد هي عدوى تنتقل عن طريق الغذاء بسبب استهلاك الطعام أو الماء الملوث ببكتيريا السالمونيلا المعوية

طريقة الإرسال:

يحدث الانتقال من مضيف إلى مضيف إذا تم تناول طعام ملوث يمثل هذه المواد البرازية (المسار البرازي الفموي)

العلامات والأعراض

- الشعور بالضيق واللسان المغطى
- الصداع والسعال.
- من الممكن أيضًا أن يكون هناك ألم في البطن.
- قد يتم الكشف عن بقع الورد
- انتفاخ البطن مع الإمساك، أكثر من الإسهال عند البالغين

- يمكن أن يحدث الإسهال في هذه المرحلة: ستة إلى ثمانية براز في اليوم، لونه أخضر مع رائحة البازلاء –رائحة الحساء.
- يتضخم الطحال والكبد (تضخم الكبد الطحال) ويصبحان مؤلمين.

وقاية

- تجنب الأطعمة الملوثة.
- غسل اليدين خاصة قبل تحضير الطعام وتناوله
- تناول لقاح التيفوئيد

5- كوفيد 19

فيروسات كورونا هي عائلة من الفيروسات التي يمكن أن تسبب أمراضًا مثل نزلات البرد ومتلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس). في عام 2019، تم تحديد فيروس كورونا جديد كسبب لتفشي المرض الذي نشأ في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر 2019.

طريقة الإرسال:

- يقوم الأشخاص المصابون بزفير تلك الجزيئات أثناء التنفس أو التحدث أو السعال أو العطس أو الغناء
- يتم استنشاقه أو هبوطه على الأغشية المخاطية في العينين أو الأنف أو الفم لإصابته.
- لمس سطح أو جسم ملوث قبل لمس فمهم أو أنفهم أو أعينهم.

العلامات والأعراض:

- ألم
- صداع
- تعب
- ضيق في التنفس
- قلق
- اكتئاب
- حمى
- السعال المزمن
- مشكلة النوم

وقاية

- ارتدي قناعًا يغطي أنفك وفمك. تأكد من أن يديك نظيفة عند ارتداء القناع وإزالته.
- حافظ على مسافة جسدية لا تقل عن متر واحد من الآخرين.
- تجنب الأماكن سيئة التهوية أو المزدحمة.
- افتح النوافذ لتحسين التهوية في الداخل.
- اغسل يديك بانتظام.
- عندما يأتي دورك، احصل على التطعيم.
- قم بتنظيف يديك بانتظام في كثير من الأحيان. استخدم الصابون والماء المحتوي على الكحول.
- احصل على التطعيم الكامل أو عزز مناعتك.

دور التمريض في الوقاية من الأمراض المعدية

- 1- ويجب أن تتجاوز برامج الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها مجرد توفير الأدوية والعلاج.
- 2- مراقبة وتقديم خدمات إدارة الحالات للأفراد المصابين بالأمراض المعدية
- 3- يجب أن يهدف التشخيص الصحي وتعزيزه إلى تغيير سلوك الفرد والمجتمع
- 4- يجمع ويحلل ويبلغ عن الأمراض المعدية والبيانات الوبائية
- 5- يجري دراسات الأمراض المعدية والوبائية وغيرها تحت التوجيه والتعاون مع مسؤول الصحة ومدير الأمراض المعدية
- 6- العمل كمورد وتقديم الاستشارات والمعلومات الصحية للأفراد، العائلي.
- 7- إن حشد المشاركة المجتمعية أمر ضروري لنجاح تنفيذ البرنامج.

2- الأمراض غير المعدية

أهداف التعلم

في نهاية الفصل سيكون الطالب قادرًا على:- 1- تعريف الأمراض غير المعدية

- 2- عوامل الخطر الحكومية للأمراض غير المعدية
- 3- اذكر أمثلة على الأمراض غير المعدية الشائعة
- 4- تحديد الوقاية من الأمراض غير المعدية
- 5- اذكر دور التمريض في رعاية المرضى المصابين بالأمراض المعدية

تعريف الأمراض غير المعدية

الحالات المزمنة التي لا تنتج عن عملية معدية وغير معدية

عوامل الخطر للأمراض غير المعدية

- الوراثة.
- بدانة.
- انقطاع التنفس أثناء النوم.
- التقدم في السن.
- العرق/العرق.
- زيادة تناول الصوديوم.
- مرض السكري.
- التدخين.
- قلة ممارسة الرياضة البدنية.

أمثلة على الأمراض المعدية الشائعة

1- مرض القلب الإقفاري

تعريف مرض القلب الإقفاري

- مرض القلب الإقفاري هو انسداد تدفق الدم
- من خلال الشرايين التاجية إلى خلايا عضلة القلب، عادة
- من تصلب الشرايين. انخفاض تدفق الدم الناتج
- من مرض القلب التاجي يمكن أن يسبب الذبحة الصدرية أو احتشاء عضلة القلب أو الموت المفاجئ إذا كان الدم
- لم يتم استعادة التدفق.

أنواع أمراض القلب الإقفارية

1- الذبحة الصدرية.

2- متلازمة الشريان التاجي الحادة.

• الذبحة الصدرية غير المستقرة.

• احتشاء عضلة القلب (MI).

أ. الذبحة الصدرية

الذبحة الصدرية المستقرة

هذا هو النوع الأكثر شيوعًا من الذبحة الصدرية، وعادةً ما يحدث الألم بسبب:

المجهود البدني الذي يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب. يتم تعريف هذا النوع من الذبحة الصدرية بأنه مستقر لأنه يوجد نمط منتظم للألم وتوجد محفزات مماثلة لكل نوبة من الذبحة الصدرية.

الذبحة الصدرية المتغيرة أو التشنجية الوعائية (ذبحة برينز ميتال).

يحدث هذا النوع من الذبحة الصدرية بسبب تشنجات الشريان التاجي وهو خطير. غالبًا ما يكون نمط الحدوث دوريًا، مع ظهور الألم في نفس الوقت تقريبًا كل يوم.

ب. متلازمة الشريان التاجي الحادة

• الذبحة الصدرية غير المستقرة

الذبحة الصدرية غير المستقرة لا تتبع نمطًا منتظمًا. كمية صغيرة من المادية

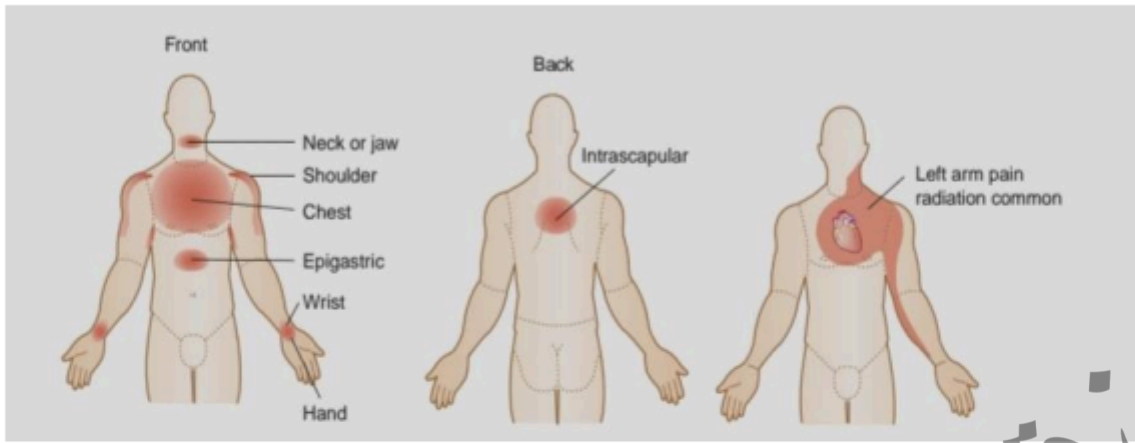
يمكن أن يؤدي بذل مجهود مثل المشي، أو حتى مجرد الراحة، إلى حدوث نوبة. في كثير من الحالات، يمكن أن تتطور الذبحة الصدرية المستقرة إلى ذبحة صدرية غير مستقرة، مما قد يكون مؤشرًا على تفاقم أمراض القلب التاجية.

• احتشاء عضلة القلب

علامات وأعراض مرض القلب الإقفاري

1- غالبًا ما يصف المرضى (خاصة الرجال) الألم بأنه ثقل أو ضيق أو ضغط أو يشبه الرؤية أو سحق في وسط الصدر أو بجوار الصدر.

2- يمكن أن ينتشر الألم إلى أسفل إحدى الذراعين أو كليهما، ويكون الألم في الذراع اليسرى أكثر شيوعًا، إلى الكتف أو الرقبة أو الفك أو الظهر.



3- وقد يصف المرضى أيضًا ثقلًا في أذرعهم أو شعورًا بالهلاك الوشيك.

4- أثناء نوبة الألم، قد يصبح المريض شاحبًا، أو يعاني من التعرق، أو ضيق التنفس.

5- عادة ما يحدث الألم نتيجة المجهود ويختفي مع الراحة.

6- يمكن تخفيفه باستخدام موسع للأوعية الدموية مثل NTG.

7- قد تزداد نوبات ألم الصدر من حيث التكرار والشدة بمرور الوقت. إذا لم يستجب المرضى للتحذير بالتوقف عن نشاطهم والراحة، فقد يكونون معرضين لخطر الإصابة بنوبة قلبية أو الموت المفاجئ.

8- خذ بعين الاعتبار كبار السن الذين قد لا يكون لديهم ألم في الصدر بسبب الاعتلال العصبي بسبب احتشاء عضلة القلب.

9- عند النساء، قد تشمل أعراض احتشاء عضلة القلب أيضًا عدم الراحة في البطن، أو التعب، أو حرقة المعدة، أو آلام الظهر، حيث يكون التعب هو المؤشر الأكبر.

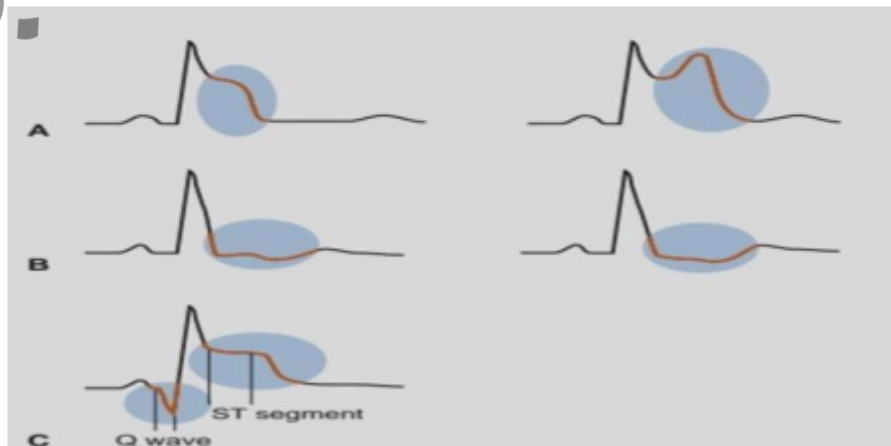
10- الغثيان والقيء.

11- تغيرات في مستوى الوعي (LOC) دون أسباب أخرى.

12- نوبات الإغماء أو ما يقرب من الإغماء.

التقييم التشخيصي لمرض القلب الإقفاري

1- تخطيط القلب.



- 2- التروبونين القلبي في الدم I أو T.
- 3- الميوجلوبيين في المصل.
- 4- مصل CK-MB.
- 5- سي بي سي.
- 6- المغنيسيوم والبوتاسيوم في الدم.
- 7- العلامات الحيوية، تشبع الأكسجين، المدخول والإخراج.
- 8- تخطيط صدى القلب.
- 9- التدخلات التاجية المحتملة: قسطرة الشرايين التاجية عبر الجلد (PTCA)، قسطرة الشرايين التاجية، الدعامات، استئصال اللويحات، أجهزة مساعدة البطين الأيسر، أو مجازة القلب.

إدارة المريض المصاب بمرض القلب الإقفاري

الإدارة الطبية 1- الأكسجين.

- 2- كبريتات المورفين.
- 3- نترات. توسيع الأوعية الدموية لتقليل التحميل المسبق والتحميل اللاحق. تقليل استهلاك الأكسجين لعضلة القلب.
- 4- Fab أربعة أدوية للقلب: الأسبرين، الستاتين، ACEI، حاصرات بيتا.
- مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين
- منع إنتاج الأنجيوتنسين II، وهو مضيق قوي للأوعية الدموية. توسيع الأوعية الدموية وتحسين النتاج القلبي وتحمل التمارين الرياضية.
- حاصرات قنوات الكالسيوم
- توسيع الشرايين الطرفية، تقليل انقباض عضلة القلب، الاكتئاب نظام التوصيل، وتقليل عبء العمل على القلب. في الذبحة الصدرية المتغيرة، تقليل تشنج الشريان التاجي.
- حاصرات بيتا
- تقليل النبض وضغط الدم والنتاج القلبي وقمع نشاط الرنين. تقليل خطر الموت المفاجئ.
- 5- مثبطات تراكم الصفائح الدموية.
- تثبيط تنشيط الصفائح الدموية، أو الالتصاق، أو نشاط التخثر.
- 6- التخثر.
- 7- مضادات التخثر.

8- مضاد لاضطراب النظم القلبي.

9- موسعات الأوعية الدموية.

10- التدخلات التاجية عن طريق الجلد والدعامات.

2- مرض السكري

تعريف مرض السكري

مرض السكري هو مجموعة من الأمراض الأيضية التي تتميز بارتفاع السكر في الدم الناتج عن عيوب في إفراز الأنسولين أو عمل الأنسولين أو كليهما.

تصنيف مرض السكري

(منظمة الصحة العالمية) لجنة الخبراء المعنية بمرض السكري

مرض السكري الذي يصنف مرض السكري على أساس عمر ظهور المرض، بشكل رئيسي:

1- مرض السكري الذي يصيب الأطفال (النوع الأول)

2- مرض السكري عند النضج (النوع 2)

3- سكري الحمل (GDM)

علامات وأعراض مرض السكري

1- بولي يوريا

2- تعدد البلع

3- العطاش

طرق تشخيص مرض السكري

1- $HbA1c \geq 6.5\%$

2- نسبة الجلوكوز في الدم أثناء الصيام

3- جلوكوز البلازما لمدة ساعتين أثناء اختبار تحمل الجلوكوز عن طريق الفم (OGTT)

4- جلوكوز البلازما العشوائي

علاج مرض السكري

1- العلاج الغذائي الطبي

الحفاظ على مستويات الجلوكوز والدهون في الدم قريبة من المعدل الطبيعي قدر الإمكان للوقاية

مضاعفات طويلة الأمد. بالنسبة للبعض، وخاصة المصابين بداء السكري من النوع 2، فقدان الوزن

وقد يكون التحكم في الكوليسترول وضغط الدم أهدافًا إضافية للعلاج الغذائي.

2- ممارسة

- تعمل التمارين الرياضية على خفض نسبة السكر في الدم عن طريق تحسين حساسية العضلات للأنسولين، ويمكن أن تستمر تأثيراتها لمدة تصل إلى 48 ساعة.
- تعمل التمارين الرياضية أيضًا على تحسين مستويات الدهون في الدم والدورة الدموية، وهو أمر مهم للشخص المصاب بداء السكري والذي لديه بالفعل خطر متزايد للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

3- **دواء أ- حقن الأنسولين.** الشخص المصاب بداء السكري من النوع الأول ليس لديه مرض داخلي المنشأ الأنسولين ولذلك يجب حقن الأنسولين يوميًا.

ب- **أدوية خفض سكر الدم عن طريق الفم.** قد يتمكن المريض المصاب بداء السكري من النوع 2 من التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم من خلال العلاج الغذائي الطبي وممارسة الرياضة وحدهما.

3- سرطان

تعريف السرطان:

سرطان هي مجموعة من الخلايا التي تنمو بشكل خارج عن السيطرة، وتتولى وظيفة العضو المصاب.

تصنيف السرطان:

1- **سرطان** هو النوع الأكثر شيوعًا من السرطان ويشمل خلايا الجلد، الجهاز الهضمي (GI)

2- **السااركوما** هي خلايا سرطانية تؤثر على النسيج الضام، بما في ذلك الدهون، والغمد الذي يحتوي على الأعصاب والغضاريف والعضلات والعظام.

3- **اللوكيميا** هو المصطلح المستخدم لوصف النمو غير الطبيعي لخلايا الدم البيضاء (WBCs).

4- **الأورام اللمفاوية** السرطانات التي تصيب خلايا الجهاز الليمفاوي والعقد الليمفاوية والطحال .

تشخيص السرطان:

- 1- خزعة.
- 2- الإجراءات الإشعاعية.
- 3- إجراءات التصوير النووي.
- 4- إجراءات الموجات فوق الصوتية.
- 5- التصوير بالرنين المغناطيسي.
- 6- الإجراءات التنظيرية.
- 7- الفحوصات المخبرية.
- 8- دراسة خلوية.

علاج السرطان

1- جراحة.

يمكن أن تكون الجراحة علاجية عندما يكون من الممكن إزالة الورم بأكمله. جلد يمكن إزالة السرطانات والأورام المحددة جيدًا دون ورم خبيث دون أي تدخل إضافي. بالنسبة لبعض الأورام، تتم إزالة أكبر قدر ممكن من الورم (وهذا ما يسمى تقليص الحجم)، ويتم استخدام العلاج الكيميائي أو الإشعاعي للمتابعة لعلاج الخلايا السرطانية المتبقية.

2- إشعاع.

يستخدم الإشعاع بشكل شائع في السيطرة على السرطان وتخفيفه، ويمكن أن يكون علاجياً إذا كان المرض موضعياً. يعتمد قرار استخدام الإشعاع عادةً على موقع السرطان وحجمه. يدمر الإشعاع الخلايا السرطانية من خلال التأثير على بنية الخلية وبيئة الخلية. يتم استخدامه بجرعات مجزأة (مقسمة) لمنع الآثار الجانبية المدمرة.

3- العلاج الكيميائي.

هو العلاج الكيميائي الذي يستخدم **التسمم الخلوي** أدوية لعلاج السرطان، يمكن استخدام الأدوية السامة للخلايا لعلاج الأورام السرطانية أو السيطرة عليها أو تخفيفها. يتم تصنيفها وفقًا لكيفية تأثيرها على نشاط الخلية.

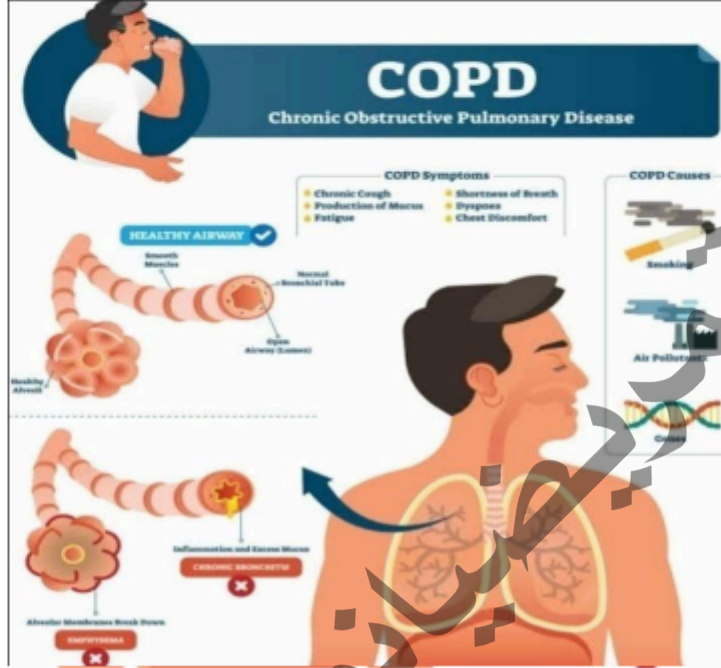
4- أمراض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)

تعريف

هو اسم لمجموعة من أمراض الرئة التي تسبب صعوبات في التنفس مثل (انتفاخ الرئة، التهاب الشعب الهوائية المزمن)

• انتفاخ الرئة: تلف الأكياس الهوائية في الرئتين

• التهاب الشعب الهوائية المزمن: التهاب مجرى الهواء على المدى الطويل



العلامات والأعراض:

- 1- ضيق التنفس خاصة عند النشاط
- 2- سعال صدري مستمر مع بلغم
- 3- عدوى الصدر المتكررة
- 4- الصفير المستمر

علاج مرض الانسداد الرئوي المزمن:

- 1- أجهزة الاستنشاق والأدوية للمساعدة في تسهيل التنفس
- 2- إعادة التأهيل الرئوي – برنامج متخصص للتمرين والتعليم
- 3- توقف عن التدخين
- 4- الجراحة أو زراعة الرئة

الوقاية من الأمراض غير المعدية

اتبع أسلوب حياة صحي على النحو التالي:

أ- تغذية

- تناول الطعام الذي يحتوي على جميع العناصر الغذائية
 - تجنب الأطعمة الدهنية
 - تجنب إضافة الكثير من السكر أو الملح إلى طعامك
 - تجنب تناول الكثير من الكربوهيدرات في طعامك خاصة لمرضى السكري.
 - تناول وجبات صغيرة متكررة
 - شرب كميات كبيرة من الماء لا تقل عن 2 لتر يوميا
- ب- ممارسة الرياضة بانتظام على الأقل المشي يوميًا لمدة 30 دقيقة ج- تجنب التوتر
د- الإقلاع عن التدخين ه- تجنب الكحول ف- فقدان الوزن

1

دور التمريض في رعاية المرضى المصابين بالأمراض غير المعدية

- 1- الوقاية والعلاج والإدارة
- 2- اكتشاف المرضى وعلاجهم وإحالتهم
- 3- نقطة الاتصال الأولى
- 4- توفير التدخلات السلوكية ونمط الحياة
- 5- مراقبة ضغط الدم ومستوى الجلوكوز في الدم بانتظام.
- 6- تثقيف المريض حول كيفية اتباع نمط حياة صحي
- 7- اطلب من المريض اتباع نظام الدواء وفقًا لأمر الطبيب
- 8- تثقيف المريض حول الأعراض المحتملة التي تتطلب زيارة الطبيب مثل ألم في الصدر، صداع شديد، ارتفاع السكر في الدم، سقوط الوجه، عدم القدرة على الحركة، ضيق التنفس.
- 9- تشجيع المرضى على زيادة معرفتهم بالمرض
- 10- الدعوة إلى سياسات صحية تدمج الأمراض غير المعدية الوقاية في التخطيط الصحي.

السكان المعرضون للخطر ورعايتهم

أهداف التعلم

- في نهاية الفصل سيكون الطالب قادرًا على:- 1- تحديد السكان المعرضين للخطر 2- فئات الدولة من السكان المعرضين للخطر 3- قائمة المبادئ لرعاية السكان المعرضين للخطر 4- ذكر رعاية السكان المعرضين للخطر

مقدمة:

على الرغم من أن كلمة 'ضعيف' تُستخدم الآن على نطاق واسع في الرعاية الصحية والاجتماعية، إلا أن تعريفها الدقيق لا يزال بعيد المنال. ويرجع ذلك جزئيًا إلى عالميتها وديناميكيته حيث يصبح الجميع أو يشعرون بالضعف بدرجة أكبر أو أقل في أوقات مختلفة من حياتهم. هناك أيضًا العديد من الأسباب الأخرى. وتشمل هذه حقيقة أن لها مجموعة متنوعة من المعاني، مثل أن الشخص في خطر، ومعرض للخطر تحت التهديد، وعرضة للمشاكل، وعاجز، ويحتاج إلى الحماية والدعم

تعريف السكان المعرضين للخطر

تلك المجموعات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بنتائج صحية ضارة.

فئات السكان المعرضين للخطر

1. الوالدين الوحيدين. يتم تعريفه عادةً على أنه أم أو أب مطلق أو منفصل أو أعزب أو أرمل يعيش بدون زوج (ولا يتعايش) مع طفله أو أطفاله المعالين غير المتزوجين مطلقًا.

الأشخاص ذوي الإعاقة:

سيتم استخدام مصطلح 'الإعاقة' بمعناه الأوسع وسيشير إلى الإعاقات الجسدية والعقلية.

2. كبار السن. يعيش بعض كبار السن حياة مستقلة ونشطة، ويشاركون ويساهمون في أسرهم ومجتمعاتهم بطرق عديدة. ومع ذلك، فإن آخرين هم من بين الأكثر استبعادًا اجتماعيًا وضعفًا في المجتمع.

3. طفولة. لم تكن الطفولة مرحلة مميزة من مراحل الحياة في معظم الثقافات حيث لم يكن يُنظر إلى الأطفال على أنهم مختلفون بشكل كبير عن البالغين. على سبيل المثال، تم دمجهم في الحياة العملية والاجتماعية للبالغين، وتم معاملتهم وارتداء ملابسهم كبالغين مصغرين تولوا تدريجيًا أدوار البالغين ونضجوا ببطء حتى مرحلة البلوغ.

4. المرضى العقليين.

يعاني العديد من الأشخاص من مشاكل نفسية حقيقية ولكنهم لا يتلقون أي مساعدة أبدًا.

5. المشردين. وتشمل هذه الأسباب حقيقة أنهم لا يشعرون بالأمان العاطفي في منازلهم، وليس لديهم أي حق في البقاء هناك، وإذا كان سكنهم دون المستوى المطلوب ويؤثر سلبًا على صحتهم. يفترض الكثير من الناس ذلك التشرد يعني النوم في الشوارع. إنه مفهوم أوسع بكثير حيث يمكن أن يكون الشخص أو الأسرة بلا مأوى لعدة أسباب مختلفة.

مبادئ رعاية الفئات السكانية الضعيفة:

- 1- التمكين.
- 2- حماية.
- 3- وقاية.
- 4- التناسب.
- 5- شراكة.
- 6- مسئولية.

رعاية السكان المعرضين للخطر:

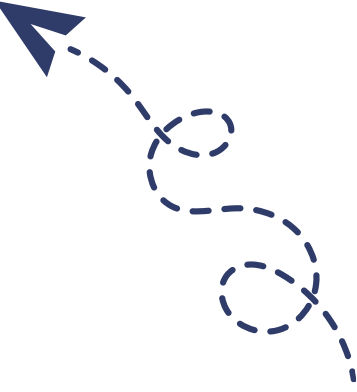
- 1- التعرف على السكان المعرضين للخطر
- 2- فحص المريض
- 3- توفير التطعيمات الإلزامية للأطفال من قبل وزارة الصحة واستخدام القانون لمن يفوت جرعة التطعيم
- 4- توفر المرافق الصحية العامة خدمات صحة الأم والطفل.
- 5- تقديم الدعم المالي للوالدين الوحيدين من قبل وزارة الرعاية الاجتماعية
- 6- توفير أجهزة مساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة مثل أدوات المساعدة على المشي والكراسي المتحركة والعلب.

- 7- توفير السكن للمشردين للقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع
- 8- تحسين المحددات الاجتماعية لتعزيز الحياة الصحية
- 9- الاستفادة من نظام الرعاية الصحية الوطني ذو الميزانية العالمية
- 10- توفير الوصول إلى الرعاية الصحية الافتراضية
- 11- مطابقة احتياجات الاستشفاء مع المجتمعات المحيطة
- 12- دعم الوصول إلى الرعاية الصحية المناسبة للمجتمع

من قناة نهر بطنيانو على التليجرام

مراجع

- جانجادهاران، س.، وهيماماليني، م. (2021). *تمريض صحة المجتمع: إطار الممارسة: المجلد 2-الكتاب الإلكتروني*. إلسفير للعلوم الصحية.
- ريكتور، سي، وستانلي، إم جيه (2020). *التمريض المجتمعي والصحة العامة*. ليبينكوت وويليامز وويلكينز.
- شون، ب. م، وبورتا، ج. م. (2023). *الدليل السريري للصحة العامة على أساس السكان: استخدام EBP لتحويل السياسة في التمريض والرعاية الصحية*. سيجما ثيتا تاو.
- شارما، م.، وبرانسكوم، ب.و. (2020). *مقدمة للمجتمع والجمهور صحة*. جون وايلي وأولاده.
- ستانهوب، م.، ولانكستر، ج. (2021). *أسس صحة السكان في التمريض المجتمعي/الصحي العام - كتاب إلكتروني*. إلسفير للعلوم الصحية.
- تشيلتون، س.، وبين، ه. (2025). *كتاب تمريض المجتمع*. ثالث تحرير. روتليدج



لمزيد من الملاحظات والكتب الطبية
يُرجى زيارة قناة ثانية تمريضيانو
على تطبيق التليجرام



للاضمام إلى القناة، يُرجى النقر على زر subscribe